

Lernskript

Ringvorlesung „Inklusion im Sport“

Universität Münster • SoSe 2026 • Wissens-Check am 23.07.2026

Dieses Skript fasst alle zwölf Sitzungen der Ringvorlesung zusammen und enthält sämtliche Karteikarten sowie alle Prüfungsfragen mit markierter richtiger Antwort und kurzer Begründung. Die Inhalte sind aus den Foliensätzen der Dozierenden aufbereitet; die richtige Antwort ist jeweils grün markiert und mit ✓ gekennzeichnet.

Umfang: 12 Sitzungen • 108 Karteikarten • 135 Prüfungsfragen.

Inhalt

- Sitzung 01** — Auftakt & Vorlesungskonzept (16.04 • Duensing-Knop)
- Sitzung 02** — Verhaltensauffälligkeiten im Sport (23.04 • Henning / Tietjens)
- Sitzung 03** — Emotionale & soziale Förderung (Kompassschule) (30.04 • Görlich (Kompassschule))
- Sitzung 04** — ADHS – na und?! (Skaten statt Ritalin) (07.05 • Bohn / skate-aid)
- Sitzung 05** — Kognition & Bewegung im Alter (21.05 • Voelcker-Rehage)
- Sitzung 06** — Fachdidaktische Ansätze für heterogene Lerngruppen (11.06 • Leineweber)
- Sitzung 07** — Blindenfußball in der Schule (18.06 • Winnebeck)
- Sitzung 08** — Sport mit krebserkrankten Kindern (25.06 • Boll)
- Sitzung 09** — Handball-Heroes & Special Olympics Unified (02.07 • Schneider / Hermann)
- Sitzung 10** — Teilhabe: Teilnahme, Teilgabe, Teilsein (09.07 • Jürgens)
- Sitzung 11** — Inklusion & Exklusion im Leistungssport (16.07 • Konjer)

Sitzung 01 — Auftakt & Vorlesungskonzept

16.04 · Duensing-Knop

Zusammenfassung

Rahmen der Ringvorlesung: Inklusion als Beispiel für die Sportwissenschaft als Querschnittswissenschaft — plus Leistungen und Prüfungsform.

Ziel der Ringvorlesung ist es, erste Bezüge zu heterogenen Zielgruppen im Sport herzustellen, heterogenitätsspezifische Fragen interdisziplinär zu behandeln und am Beispiel Inklusion die Sportwissenschaft als Querschnittswissenschaft deutlich zu machen. Die heterogenitätsspezifischen Fragen sollen interdisziplinär bearbeitet werden, u.a. aus medizinischer, pädagogischer, bewegungswissenschaftlicher, didaktischer, soziologischer, trainingswissenschaftlicher, historischer, ethischer, sportpsychologischer und politologischer Perspektive. Die Ringvorlesung ist Teil von Modul 5, das im 4. Fachsemester Vorlesung und Seminar 'Unterrichten im Sport' und im 5. Fachsemester die Ringvorlesung 'Inklusion im Sport' umfasst; als Modulabschlussprüfung (MAP) dient eine 60-minütige Klausur. Die Studienleistung besteht aus drei Leistungspunkten: Teilnahme an der Vorlesung, Bestehen eines Wissens-Checks mit ca. 30 Multiple-Choice-Fragen am Semesterende und Verfassen eines 5-seitigen Reflexionsberichts. Ausprägungen von Heterogenität reichen von Alter, Geschlecht, Kultur und sozialer Herkunft bis zu Motorik, Begabung, Motivation und Sprache und werden von verschiedenen sportwissenschaftlichen Teildisziplinen beleuchtet.

Karteikarten (10)

- 1. Was soll am Beispiel Inklusion in der Ringvorlesung deutlich gemacht werden?**
Dass die Sportwissenschaft eine Querschnittswissenschaft ist.
- 2. Welche Prüfungsform (MAP) schließt Modul 5 ab?**
Eine 60-minütige Klausur.
- 3. Worin besteht der zweite Leistungspunkt der Studienleistung?**
Im Bestehen eines Wissens-Checks am Semesterende mit ca. 30 Multiple-Choice-Fragen.
- 4. Wie definiert die Vorlesung (nach Ziemer 2009) Inklusion?**
Als Überwindung sozialer Ungleichheit, Aussonderung und Marginalisierung, indem alle Menschen in ihrer Vielfalt und Differenz wahrgenommen, wertgeschätzt und anerkannt werden.
- 5. Welche zwei Perspektiven auf Behinderung werden unterschieden?**
Die medizinische (essentialistische) Perspektive (Behinderung als Krankheit) und die sozialwissenschaftliche Perspektive (Behinderung entsteht in Interaktion/durch Benachteiligung).
- 6. Umfang und Abgabetermin des Reflexionsberichts?**
5-seitiger Reflexionsbericht; Abgabe Mitte September.
- 7. Wie viele Menschen in Deutschland haben einen Grad der Behinderung über 50%?**
Rund 7,8 Mio. Menschen (ca. 9,4 % der Bevölkerung).
- 8. Wie definiert die UN-BRK 'Menschen mit Behinderungen'?**
Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.
- 9. Wofür stehen bei der Bezirksregierung Münster aktuell 'Integration' und 'Inklusion'?**
Integration = Eingliederung geflüchteter Menschen; Inklusion = gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf.

10. Wie viele SuS hatten 2020 sonderpädagogischen Förderbedarf und wie viel Prozent wurden inklusiv beschult?

582.418 Kinder und Jugendliche mit SPF (Förderquote 7,7 %), davon 44,4 % inklusiv beschult.

Prüfungsfragen (13)

1. Was soll die Ringvorlesung am Beispiel Inklusion verdeutlichen?

- a) Dass die Sportwissenschaft eine Querschnittswissenschaft ist ✓
- b) Dass die Sportmedizin die Leitdisziplin des Sports ist
- c) Dass Inklusion vor allem ein Trainingswissenschaftliches Thema ist
- d) Dass Sportdidaktik von anderen Fächern unabhängig arbeitet

Warum: Nur die Querschnittswissenschaft wird als Ziel genannt; die übrigen Optionen widersprechen dem interdisziplinären Anspruch der Vorlesung.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz – Ziele

2. Welche Prüfungsform ist als Modulabschlussprüfung (MAP) in Modul 5 vorgesehen?

- a) Eine mündliche Prüfung von 30 Minuten
- b) Ein benoteter Praxistest im Sportunterricht
- c) Eine 60-minütige Klausur ✓
- d) Eine schriftliche Hausarbeit von 15 Seiten

Warum: Als MAP ist ausdrücklich eine 60-minütige Klausur genannt; die anderen Prüfungsformen kommen im Foliensatz nicht vor.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz – Modulstruktur

3. Woraus besteht der zweite Leistungspunkt der Studienleistung?

- a) Aus einem mündlichen Referat in der Vorlesung
- b) Aus dem Bestehen eines Wissens-Checks mit ca. 30 MC-Fragen ✓
- c) Aus der regelmäßigen Teilnahme an der Vorlesung
- d) Aus dem Verfassen eines 5-seitigen Reflexionsberichts

Warum: Teilnahme ist der erste und der Reflexionsbericht der dritte Leistungspunkt; ein Referat ist gar nicht vorgesehen.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz – Leistungspunkte

4. Welche Perspektive versteht Behinderung als Krankheit mit Ursachen und Symptomen, für die ein Förderplan erstellt werden muss?

- a) Die sozialwissenschaftliche Perspektive
- b) Die interaktionistische Perspektive
- c) Die politologische Perspektive
- d) Die medizinische (essentialistische) Perspektive ✓

Warum: Die sozialwissenschaftliche/interaktionistische Sicht verortet Behinderung in Interaktion und Umfeld, nicht als Krankheit; die politologische Perspektive wird hier nicht auf Behinderung angewandt.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz

5. Welches Ziel nennt die Vorlesung ausdrücklich für die Ringvorlesung?

- a) Erste Bezüge zu heterogenen Zielgruppen im Sport herzustellen ✓
- b) Die Grundlagen der Sportmedizin systematisch zu vermitteln
- c) Prüfungsaufgaben für das Praxissemester zu entwickeln
- d) Eine eigene empirische Studie zur Inklusion durchzuführen

Warum: Nur das Herstellen erster Bezüge zu heterogenen Zielgruppen ist als Ziel genannt; die übrigen Optionen sind nicht Gegenstand der Ringvorlesungsziele.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz

6. Wann trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft?

- a) am 26.03.2009 ✓

- b) am 03.05.2008
- c) am 17.07.2002
- d) am 10.10.2014

Warum: 03.05.2008 ist das internationale Inkrafttreten, 17.07.2002 die Plagiats-Resolution des Hochschulverbandes, 2014 ein Publikationsjahr.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz – UN-BRK

7. Welche Quote setzt inklusiv beschulte SuS mit Förderbedarf ins Verhältnis zu ALLEN SuS?

- a) Exklusionsquote
- b) Förderquote
- c) Inklusionsquote ✓**
- d) Inklusionsanteil

Warum: Die Förderquote bezieht alle SuS mit Förderbedarf ein, der Inklusionsanteil nur die inklusiv beschulten, die Exklusionsquote die Förderschüler.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz – Begriffe

8. Welcher Artikel der UN-BRK betrifft Teilhabe an Erholung, Freizeit und Sport?

- a) Artikel 24
- b) Artikel 12
- c) Artikel 9
- d) Artikel 30 ✓**

Warum: Artikel 24 betrifft die Bildung; Artikel 12 und 9 werden im Foliensatz nicht als einschlägig genannt.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz – Artikel 30

9. Wie versteht die sozialwissenschaftliche Perspektive Behinderung laut Sitzung 01?

- a) Als Krankheit mit Ursachen und Symptomen
- b) Als Ergebnis von Benachteiligung im Umfeld ✓**
- c) Als angeborenes, unveränderliches Merkmal
- d) Als individuell zu behandelndes Defizit

Warum: Die anderen entsprechen der medizinischen (essentialistischen) Sicht, von der sich die sozialwissenschaftliche Perspektive gerade abkehrt.

Beleg: Sitzung 01 (Duensing-Knop), Foliensatz

10. Wodurch entsteht laut UN-BRK-Definition (sozialwissenschaftliche Perspektive) eine Behinderung von Menschen mit langfristigen Beeinträchtigungen?

- a) Durch eine ärztlich festgestellte Krankheit mit eindeutigen Ursachen und Symptomen
- b) Durch die Wechselwirkung der Beeinträchtigungen mit verschiedenen Barrieren ✓**
- c) Durch das Fehlen eines sonderpädagogischen Behandlungs- und Förderplans
- d) Durch angeborene, unveränderliche Merkmale des betroffenen Menschen

Warum: Die BRK verortet Behinderung ausdrücklich in der Wechselwirkung mit Barrieren, während die anderen Optionen der medizinisch-essentialistischen Sicht entsprechen, von der sie sich abkehrt.

Beleg: Foliensatz Auftaktsitzung SoSe 2026 (Duensing-Knop), sozialwissenschaftliche Perspektive / BRK

11. In welchem Zusammenhang verwendet die Bezirksregierung Münster laut Folien aktuell den Begriff 'Integration'?

- a) Für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Förderbedarf
- b) Für die Überwindung sozialer Ungleichheit und Marginalisierung
- c) Für die personelle und sächliche Ausstattung von Förderschulen
- d) Für die Eingliederung von geflüchteten Menschen ✓**

Warum: Den gemeinsamen Unterricht beschreibt laut Folien der Begriff Inklusion, nicht Integration; die übrigen Optionen werden dem Integrationsbegriff dort nicht zugeordnet.

Beleg: Foliensatz Auftaktsitzung SoSe 2026 (Duensing-Knop), aktueller Begriffsgebrauch Integration/Inklusion

12. Wie hoch war die Förderquote in Deutschland im Jahr 2020?

- a) 7,7 % ✓
- b) 9,4 %
- c) 44,4 %
- d) 3,42 %

Warum: 9,4 % ist der Bevölkerungsanteil mit einem Grad der Behinderung über 50 %, 44,4 % der inklusiv beschulte Anteil und 3,42 % die Inklusionsquote.

Beleg: Foliensatz Auftaktsitzung SoSe 2026 (Duensing-Knop), Zahlen rund um Inklusion

13. Welche Kennzahl setzt alle SuS mit Förderbedarf ins Verhältnis zu allen SuS in Deutschland?

- a) Inklusionsquote
- b) Inklusionsanteil
- c) Förderquote ✓
- d) Exklusionsquote

Warum: Inklusionsquote und Inklusionsanteil beziehen sich nur auf inklusiv beschulte SuS, die Exklusionsquote nur auf die Förderschülerinnen und -schüler.

Beleg: Foliensatz Auftaktsitzung SoSe 2026 (Duensing-Knop), Was meinen die Begriffe?

Sitzung 02 — Verhaltensauffälligkeiten im Sport

23.04 · Henning / Tietjens

Zusammenfassung

Was heißt 'auffällig'? Normbegriffe, Klassifikation (ICD/DSM, dimensional) und was das für den Sportunterricht bedeutet.

Ein nicht erwartetes oder nicht adäquat erscheinendes Verhalten wird als auffällig bezeichnet; Maßstab der Bewertung sind kulturelle, gesellschaftliche und soziale Normen (Fröhlich-Gildhoff, 2013). Verhaltensauffälligkeiten sind demnach Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen. Was als 'normal' gilt, lässt sich über fünf Normbegriffe fassen: soziale Norm (Orientierung an der Gruppe), statistische Norm (was die Mehrheit kann), funktionale Norm (Erfüllung vorgegebener Anforderungen), ideale Norm (Orientierung am Ideal) und subjektive Norm (was man selbst für richtig hält). Verhaltensstörungen werden über kategoriale Klassifikationssysteme wie den ICD (WHO) und das DSM (APA) klassifiziert; diese beschreiben einzelne Störungsbilder anhand der Symptome, enthalten jedoch nichts zu Ursachen und Therapien. Im ICD-10 stehen psychische und Verhaltensstörungen im Kapitel F (F00-F99). Neben der kategorialen nutzt die dimensionale Klassifikation (Petermann et al., 2002) drei Cluster: internalisierte Auffälligkeiten (z.B. sozialer Rückzug, Ängstlich/Depressiv), externalisierte Auffälligkeiten (z.B. dissoziales, aggressives Verhalten, AD(H)S) und gemischte Auffälligkeiten (z.B. soziale Probleme, Konzentrationsprobleme). Für den Sport gilt: Krankheitsbilder kennen und in der Planung berücksichtigen, aber auf individueller Ebene grundsätzlich keine Notwendigkeit, etwas anders zu machen – mit Ausnahmen wie Anorexie (vermitteltes Körperbild) und Epilepsie (einige Aktivitäten gefährlich/nicht möglich).

Karteikarten (11)

1. Wodurch wird bewertet, ob ein Verhalten als 'auffällig' gilt?

Der Maßstab sind kulturelle, gesellschaftliche und soziale Normen; auffällig ist ein nicht erwartetes oder nicht adäquat erscheinendes Verhalten (Fröhlich-Gildhoff, 2013).

2. Welche fünf Normbegriffe werden zur Bestimmung von 'normal' unterschieden?

Soziale, statistische, funktionale, ideale und subjektive Norm.

3. Was besagt die statistische Norm?

Normal ist, was die Mehrheit kann; bestimmt über die Auftretenswahrscheinlichkeit in großen Populationen, in der Regel unter Annahme einer Normalverteilung.

4. Was leisten ICD und DSM – und was nicht?

Sie beschreiben einzelne Störungsbilder anhand der Symptome; sie enthalten nichts zu Ursachen und Therapien.

5. Wie unterscheiden sich Prävalenz und Inzidenz?

Prävalenz: Anzahl aller Erkrankten in einer Population. Inzidenz: Anzahl neu auftretender Fälle pro Zeiteinheit unter den noch Erkrankbaren.

6. Welche zwei Ausnahmen erfordern im Sportunterricht doch besondere Beachtung?

Anorexie (welches Körperbild vermittelt wird) und Epilepsie (einige Aktivitäten sind gefährlich/nicht möglich).

7. Was beschreibt die Prävalenz einer psychischen Störung?

Anzahl aller Erkrankten geteilt durch die Größe der Population.

8. Was kennzeichnet die ideale Norm?

Normal ist, wer einen als wünschenswert/vollkommen definierten Zustand erfüllt.

9. Warum ist Epilepsie im Sport eine Ausnahme?

Sehr selten, aber einige Aktivitäten sind gefährlich oder nicht möglich.

10. Welches Beispiel nennt die Sitzung für einen Sonderfall mit Ko-Morbidität?

DCD (nach Dreiskämper, 2021) wird als Sonderfall der Ko-Morbiditäten angeführt.

11. Welche Personen sind am Grundmodell pädagogischer und therapeutischer Prozesse beteiligt (Fröhlich-Gildhoff, 2013)?

Diagnostiker:in, Lehrer:in, Klient:in und Eltern.

Prüfungsfragen (15)**1. Welche Aussage entspricht der Definition von Verhaltensauffälligkeiten (nach Fröhlich-Gildhoff, 2013)?**

a) Ein nicht erwartetes oder nicht adäquat erscheinendes Verhalten, bewertet an kulturellen, gesellschaftlichen und sozialen Normen ✓

b) Ein durch genetische Anlagen fest vorbestimmtes, unveränderliches Verhaltensmuster

c) Ein Verhalten, das ausschließlich durch neurologische Befunde des ICD definiert wird

d) Jede Abweichung vom statistischen Mittelwert einer großen Population

Warum: Die Definition stellt auf das nicht erwartete/adäquate Verhalten und soziale Normen ab, nicht auf Genetik, allein neurologische Befunde oder rein statistische Abweichung.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

2. Ein Kind erfüllt beim Einschulungstest die vorgegebenen Anforderungen und gilt deshalb als 'schulreif'. Welcher Normbegriff liegt zugrunde?

a) Ideale Norm

b) Funktionale Norm ✓

c) Statistische Norm

d) Subjektive Norm

Warum: Es geht um das Erfüllen vorgegebener Anforderungen (funktionale Norm); ideale Norm meint den Wunschzustand, statistische die Mehrheit und subjektive die eigene Auffassung.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

3. In welchem Kapitel des ICD-10 werden psychische und Verhaltensstörungen klassifiziert?

a) Kapitel G (G00-G99)

b) Kapitel R (R00-R99)

c) Kapitel F (F00-F99) ✓

d) Kapitel Z (Z00-Z99)

Warum: Laut Foliensatz stehen sie im Kapitel F; G umfasst das Nervensystem, R Symptome und Z Faktoren der Inanspruchnahme des Gesundheitswesens.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

4. Welche Zuordnung entspricht der dimensionalen Klassifikation (Petermann et al., 2002)?

a) Sozialer Rückzug zählt zu den externalisierten Auffälligkeiten

b) Aggressives Verhalten zählt zu den internalisierten Auffälligkeiten

c) Aufmerksamkeitsprobleme zählen zu den gemischten Auffälligkeiten ✓

d) Depression zählt zu den gemischten Auffälligkeiten

Warum: Aufmerksamkeitsprobleme gelten als gemischt, während sozialer Rückzug und Depression internalisiert und aggressives Verhalten externalisiert sind.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

5. Was leisten die kategorialen Systeme ICD und DSM laut Foliensatz?

a) Sie beschreiben Störungsbilder anhand der Symptome, ohne Ursachen und Therapien ✓

b) Sie liefern zu jedem Bild eine Ursache und eine Therapieempfehlung

c) Sie ordnen Verhalten ausschließlich dimensional entlang internalisiert/externalisiert

d) Sie bestimmen Prävalenzraten psychischer Störungen in Populationen

Warum: ICD und DSM beschreiben symptomorientiert ohne Ursachen/Therapien; dimensionale Einordnung und Prävalenz sind andere Aspekte der Sitzung.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

6. Welche Schlussfolgerung zieht die Sitzung im Fazit für den Sport(unterricht)?

a) Für jedes Krankheitsbild muss der Sportunterricht grundlegend umgestaltet werden

b) Krankheitsbilder sind für den Sportunterricht ohne Bedeutung

c) Krankheitsbilder kennen und einplanen, individuell aber meist nichts anders machen – außer bei Anorexie und Epilepsie ✓

d) Nur die statistische Prävalenz entscheidet, ob Sport stattfinden kann

Warum: Das Fazit betont Kennen und Berücksichtigen bei grundsätzlich keiner individuellen Änderung außer benannten Ausnahmen; die anderen über- oder unterschätzen die Bedeutung.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

7. Wie wird die Inzidenz einer psychischen Störung im Foliensatz definiert?

a) Anzahl neu auftretender Fälle pro 10.000 Personen pro Jahr ✓

b) Anzahl aller Erkrankten geteilt durch die Größe der Population

c) Anteil der Mehrheit, der ein Merkmal der Norm aufweist

d) Anzahl aller über die Lebensspanne diagnostizierten Fälle

Warum: Inzidenz meint neu auftretende Fälle pro Zeiteinheit; Option 2 beschreibt dagegen die Prävalenz.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

8. Wer setzt laut Foliensatz die soziale Norm?

a) Ausschließlich wissenschaftliche Studien und Expertenratings

b) Peers, Familie, Schule und Gesellschaft durch Regeln ✓

c) Die statistische Normalverteilung großer Populationen

d) Das rein individuelle, subjektive Empfinden der Person

Warum: Der Foliensatz nennt Peers, Familie, Schule und Gesellschaft; die übrigen Optionen beschreiben funktionale, statistische bzw. subjektive Norm.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

9. Wovon geht die Bestimmung der statistischen Norm in großen Populationen aus?

a) Von einem gesellschaftlich definierten Schönheitsideal

b) Von den Erwartungen der Peers und der Familie

c) In der Regel von einer Normalverteilung ✓

d) Von der Erfüllung vorgegebener Anforderungen

Warum: Die statistische Norm nutzt Auftretenswahrscheinlichkeiten und geht i.d.R. von einer Normalverteilung aus; die anderen nennen ideale, soziale bzw. funktionale Norm.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

10. Welche Auffälligkeit zählt in der dimensionalen Klassifikation zu den externalisierten?

a) Sozialer Rückzug

b) Körperliche Beschwerden

c) Ängstlich-depressives Verhalten

d) Aggressives Verhalten ✓

Warum: Aggressives/dissoziales Verhalten und AD(H)S sind externalisiert; die drei übrigen zählen zu den internalisierten Auffälligkeiten.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

11. Welches gehört zu den Grundprinzipien pädagogisch-therapeutischer Prozesse (Fröhlich-Gildhoff)?

a) Ausschließliche Defizitorientierung des Kindes

b) Ressourcenorientierung und Ganzheitlichkeit ✓

- c) Streng monomethodisches Vorgehen
- d) Zufalls- statt hypothesengeleitetes Arbeiten

Warum: Genannt werden hypothesengeleitet, multimodal, multimethodal, Ganzheitlichkeit und Ressourcenorientierung; die Distraktoren sind deren Gegenteil.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

12. Wie lassen sich Verhaltensauffälligkeiten funktional verstehen (Luder 2019)?

- a) Als bewusste Provokation gegenüber der Lehrkraft
- b) Als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation ✓**
- c) Als rein genetisch bedingtes Merkmal
- d) Als vorübergehende Unaufmerksamkeit ohne Bedeutung

Warum: Auffälligkeiten gelten als Bewältigungsversuch einer überfordernden Situation im Lebensumfeld; die anderen Optionen verkürzen oder verfälschen dies.

Beleg: Sitzung 02 (Henning/Tietjens), Foliensatz

13. Welche Zuordnung von Klassifikationssystem und herausgebender Organisation ist laut Foliensatz korrekt?

- a) Das ICD wird von der APA, das DSM von der WHO herausgegeben
- b) Das ICD wird von der WHO, das DSM von der APA herausgegeben ✓**
- c) Sowohl ICD als auch DSM werden von der WHO herausgegeben
- d) Sowohl ICD als auch DSM werden von der APA herausgegeben

Warum: Das ICD stammt von der WHO und das DSM von der APA, weshalb die vertauschten bzw. auf eine einzige Organisation reduzierten Optionen falsch sind.

Beleg: Foliensatz Sitzung 02 Verhaltensauffälligkeiten (Henning/Tietjens), Kategoriale Klassifikationssysteme ICD/DSM

14. Wie wird eine Verhaltensstörung im Foliensatz (Pschyrembel, 1994) charakterisiert?

- a) Ein statistisch seltenes Verhalten, allein über die Auftretenswahrscheinlichkeit in der Normalverteilung bestimmt
- b) Ein genetisch fest programmiertes, durch die Umwelt unbeeinflussbares Verhaltensmuster
- c) Ein Verhalten, das ausschließlich die ideale Norm des Schönheitsideals verletzt
- d) Eine von Normen abweichende Verhaltensweise, deutbar als Handlungsverlegenheit oder Notsignal ✓**

Warum: Die Verhaltensstörung wird als normabweichende, als Handlungsverlegenheit oder Notsignal interpretierbare Verhaltensweise definiert, nicht rein statistisch, genetisch oder auf das Schönheitsideal beschränkt.

Beleg: Foliensatz Sitzung 02 Verhaltensauffälligkeiten (Henning/Tietjens), Definition Verhaltensstörung

15. Welche zwei Prävalenzarten nennt der Foliensatz zur Erfassung der Prävalenz?

- a) Punkt- und Periodenprävalenz ✓**
- b) Punkt- und Lebenszeitprävalenz
- c) Perioden- und Lebenszeitprävalenz
- d) Inzidenz- und Punktprävalenz

Warum: Der Foliensatz nennt ausdrücklich Punkt- und Periodenprävalenz; die Lebenszeitprävalenz wird nicht genannt und Inzidenz ist keine Prävalenzart.

Beleg: Foliensatz Sitzung 02 Verhaltensauffälligkeiten (Henning/Tietjens), Prävalenz und Inzidenz

Sitzung 03 — Emotionale & soziale Förderung (Kompassschule)

30.04 • Görlich (Kompassschule)

Zusammenfassung

Emotionale und soziale Förderung an einem schulischen Lernort: Förderschwerpunkt, Diagnosekriterien, Intensivpädagogik.

Die Kompass-Schule (Standort Münster Kinderhaus) ist ein schulischer Lernort der Stadt Münster mit einem multiprofessionellen Team aus Sonderpädagogik, Jugendhilfe und Schulpsychologie; die Schulgemeinschaft ist in Primarstufe, Sekundarstufe und Villa Interim unterteilt. Ein sonderpädagogischer Förderbedarf der emotionalen und sozialen Entwicklung liegt vor, wenn Schüler:innen an der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können, sich der Erziehung nachhaltig verschließen oder die eigene bzw. die Entwicklung der Mitschüler:innen erheblich gestört oder gefährdet ist. Für die Diagnose sind mindestens drei Kriterien zu beachten: Intensität (längere Zeitdauer und höherer Schweregrad), Ökologie (Symptome in mindestens zwei Settings, davon eines die Schule) und Integration (spezifische Hilfen für gesellschaftliche Teilhabe erforderlich). Intensivpädagogische Förderung (§15) richtet sich an eine Gruppe, die durch Classroom-Management und Präventionsprogramme nicht mehr erreicht wird; sie zielt (Ricking 2016) auf bedeutsame Einstellungen und Verhaltensmuster zur Bewältigung sozialer Anforderungen und auf emotionale Stabilisierung durch ein positives Selbstkonzept – mit dem Ziel der Rückführung.

Karteikarten (8)

1. Aus welchen drei Bereichen setzt sich das multiprofessionelle Team der Kompass-Schule zusammen?

Sonderpädagogik, Jugendhilfe und Schulpsychologie.

2. Welche drei Diagnosekriterien sind beim Förderschwerpunkt emotionale/soziale Entwicklung mindestens zu beachten?

Intensität (Zeitdauer/Schweregrad), Ökologie (mind. zwei Settings, eines die Schule) und Integration (spezifische Hilfen für Teilhabe).

3. Welche zwei Ziele der Intensivpädagogik nennt Ricking (2016)?

Entwicklung bedeutsamer Einstellungen/Verhaltensmuster zur Bewältigung sozialer Anforderungen und emotionale Stabilisierung durch ein positives Selbstkonzept.

4. Wie lautet das übergeordnete lang-/kurzfristige Ziel der Förderung?

Die Rückführung (in die allgemeine Schule).

5. Wo befindet sich die Kompass-Schule?

In Münster Kinderhaus.

6. In welche drei Bereiche ist die Schulgemeinschaft unterteilt?

Primarstufe, Sekundarstufe und Villa Interim.

7. Welches Förderangebot wird laut Wittrock (2007) im Rahmen der Intensivpädagogik benötigt?

Ein präventiv orientiertes, flexibles und interdisziplinär vernetztes Förderangebot.

8. Wie sind Lerngruppen, Personal und Zeit in der intensivpädagogischen Förderung an der Kompass-Schule gestaltet?

Kleine Lerngruppen, viel Personal und viel Zeit.

Prüfungsfragen (10)

1. Aus welchen drei Professionen besteht das multiprofessionelle Team der Kompass-Schule?

a) Sonderpädagogik, Jugendhilfe und Schulpsychologie ✓

- b) Sportwissenschaft, Medizin und Sozialarbeit
- c) Sonderpädagogik, Physiotherapie und Verwaltung
- d) Regelschulpädagogik, Polizei und Schulpsychologie

Warum: Der Foliensatz nennt ausdrücklich nur Sonderpädagogik, Jugendhilfe und Schulpsychologie; die anderen Kombinationen kommen nicht vor.

Beleg: Sitzung 03 (Görlisch, Kompassschule), Foliensatz

2. Was besagt das Diagnosekriterium 'Ökologie'?

- a) Die Symptome müssen längere Zeit andauern und einen hohen Schweregrad haben
- b) Für die gesellschaftliche Teilhabe sind spezifische Hilfen erforderlich
- c) Die Symptome treten in mindestens zwei Settings auf, von denen eines die Schule ist ✓**
- d) Die Diagnose wird ausschließlich in der Schule durch Lehrkräfte gestellt

Warum: Option 1 beschreibt die Intensität und Option 2 die Integration, während Option 4 gar nicht als Kriterium vorkommt.

Beleg: Sitzung 03 (Görlisch, Kompassschule), Foliensatz

3. Worin liegt die Besonderheit der Zielgruppe intensivpädagogischer Förderung (§15)?

- a) Sie benötigt lediglich ein konsequenteres Classroom-Management
- b) Sie wird durch gängiges Classroom-Management und Präventionsprogramme nicht mehr erreicht ✓**
- c) Sie hat keinen sonderpädagogischen Förderbedarf
- d) Sie kann ausschließlich außerhalb der Schule gefördert werden

Warum: Der Foliensatz betont, dass gerade diese Gruppe die üblichen Maßnahmen nicht mehr erreicht; die übrigen Optionen widersprechen dem Förderbedarf.

Beleg: Sitzung 03 (Görlisch, Kompassschule), Foliensatz

4. Welches lang- bzw. kurzfristige Ziel wird für die intensivpädagogische Förderung genannt?

- a) Dauerhafte Beschulung am schulischen Lernort
- b) Rückführung in die allgemeine Schule ✓**
- c) Vollständige Auflösung der Lerngruppen
- d) Verzicht auf Zusammenarbeit mit außerschulischen Partner:innen

Warum: Der Foliensatz nennt ausdrücklich die Rückführung als Ziel; die anderen Optionen widersprechen der Förderlogik.

Beleg: Sitzung 03 (Görlisch, Kompassschule), Foliensatz

5. Mittels welcher einheitlichen Diagnostik wird im Förderschwerpunkt (QUA-LiS) gearbeitet?

- a) Matrix emotionaler und sozialer Kompetenzen (MesK) ✓**
- b) Verfahren zur Erfassung der Klassenführung (VEK)
- c) Skala sozialer Schulleistungen (SSS)
- d) Index für kognitive Förderplanung (IKF)

Warum: Als einheitliche Diagnostik nennt der Foliensatz ausdrücklich die Matrix emotionaler und sozialer Kompetenzen (MesK).

Beleg: Sitzung 03 (Görlisch, Kompassschule), Foliensatz

6. Welche gemeinsame pädagogische Grundhaltung wird für die Kompass-Schule genannt?

- a) Neue Autorität und Reckahner Reflexionen ✓**
- b) Offener Unterricht und Montessori-Prinzip
- c) Direkte Instruktion und Token-System
- d) Erlebnispädagogik und Peer-Tutoring

Warum: Genannt werden 'neue Autorität' und die 'Reckahner Reflexionen'; die anderen Konzepte stehen nicht im Foliensatz.

Beleg: Sitzung 03 (Görlisch, Kompassschule), Foliensatz

7. Welche Bewegungsräume werden für die Kompass-Schule genannt?

- a) **Time-Out-Raum, Yoga-Raum und Pausenhöfe** ✓
- b) Kletterhalle, Schwimmbad und Sporthalle
- c) Fitnessstudio, Tanzsaal und Aula
- d) Bolzplatz, Turnraum und Gymnastikraum

Warum: Unter 'Bewegungsräume' listet der Foliensatz Time-Out-Raum, Yoga-Raum und Pausenhöfe; die anderen sind nicht genannt.

Beleg: Sitzung 03 (Görlich, Kompassschule), Foliensatz

8. Nach AO-SF §4 (4) besteht ein sonderpädagogischer Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung u.a. dann, wenn ...

- a) die Symptome ausschließlich außerhalb der Schule und nur in einem einzigen Setting auftreten
- b) **sich eine Schülerin oder ein Schüler der Erziehung nachhaltig verschließt oder widersetzt** ✓
- c) allein die kognitive Lernleistung ohne jede Verhaltensauffälligkeit beeinträchtigt ist
- d) sich die Verhaltensprobleme durch gutes Classroom-Management vollständig beheben lassen

Warum: Der Foliensatz zitiert AO-SF §4 (4) mit dem nachhaltigen Sich-Verschließen/Widersetzen gegenüber Erziehung, während die übrigen Optionen der Ökologie-Bedingung bzw. der Förderlogik widersprechen.

Beleg: Foliensatz Sitzung 03 Kompass-Schule (Görlich), AO-SF §4 (4)

9. Wie beschreibt Baumann (2015) das, was nötig ist, um überhaupt noch Zugang zum Klientel zu finden?

- a) standardisierte Förderprogramme innerhalb der Regelschule
- b) ausschließlich konsequenteres Classroom-Management
- c) **Spezialangebote jenseits der 'pädagogischen Normalität'** ✓
- d) weitgehender Verzicht auf Diagnostik und Förderplanung

Warum: Baumann (2015) spricht ausdrücklich von 'Spezialangeboten jenseits der pädagogischen Normalität'; die anderen Optionen stehen so nicht im Foliensatz.

Beleg: Foliensatz Sitzung 03 Kompass-Schule (Görlich), Baumann 2015

10. Mit welchen außerschulischen Partner:innen arbeitet die Kompass-Schule laut Foliensatz zusammen?

- a) **KSD, Vereine, Therapeut:innen, Ärzt:innen und Kinderschutzambulanz** ✓
- b) Polizei, Ordnungsamt und Jugendgericht
- c) ausschließlich das schulinterne multiprofessionelle Team
- d) Schulaufsicht, Regelschulen und Bezirksregierung

Warum: Der Foliensatz nennt als außerschulische Partner:innen KSD, Vereine, Therapeut:innen, Ärzt:innen, Kinderschutzambulanz und Autismus-Beratung, nicht die übrigen genannten Stellen.

Beleg: Foliensatz Sitzung 03 Kompass-Schule (Görlich), Zusammenarbeit außerschulische Partner:innen

Sitzung 04 — ADHS – na und?! (Skaten statt Ritalin)

07.05 · Bohn / skate-aid

Zusammenfassung

'Skaten statt Ritalin': ADHS nach ICD-11, Wirkung von Bewegung auf exekutive Funktionen und das skate-aid-Studiendesign.

Das skate-aid-Projekt unter Federführung von Titus Dittmann richtet sich als Bewegungsangebot an Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. diagnostizierten Verhaltensstörungen; die Teilnehmenden wurden in der Praxis Dr. Dirksen & Franke in Münster behandelt und gezielt von den Ärzten für das Programm vorgeschlagen. ADHS (ICD-11 6A05) ist durch ein mindestens sechs Monate anhaltendes Muster von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität gekennzeichnet, das während der Entwicklungsphase auftritt, außerhalb normaler altersgemäßer Schwankungen liegt und die akademische, berufliche oder soziale Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Zur Wirksamkeit von Bewegung wird angenommen, dass aerobe Aktivitäten positiv auf die exekutiven Funktionen und damit auf die ADHS-Symptomatik wirken; als Hypothese gilt eine verstärkte Reifung des präfrontalen Kortex, der eng mit den exekutiven Funktionen assoziiert ist. Die Pilotstudie prüft mit einer Testbatterie (u.a. Fragebögen zu Selbstwert/Emotionsregulation, D2- und Stroop-Test, Gleichgewichts- und Sprungmessungen) zwei Hypothesen: dass Kinder mit ADHS in motorischen und kognitiven Tests schlechter abschneiden als eine Kontrollgruppe und dass eine 16-wöchige Skateboard-Intervention stärkere Verbesserungen in Kognition, Motorik und Symptomatik bewirkt.

Karteikarten (10)

- 1. Wie ist ADHS nach ICD-11 (6A05) hinsichtlich Dauer und Kernmerkmalen definiert?**
Als mindestens 6 Monate anhaltendes Muster von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität, das während der Entwicklungsphase auftritt.
- 2. In wie vielen Umgebungen muss das Verhaltensmuster zur ADHS-Diagnose erkennbar sein?**
In mehr als einer Umgebung.
- 3. Wie wirkt Methylphenidat neurobiologisch?**
Durch Reuptake-Inhibition: Hemmung des Rücktransports von Dopamin und Noradrenalin, wodurch die Botenstoffe länger wirken (v.a. im Striatum).
- 4. Welche Hypothese zur Wirkung des Skatens auf das Gehirn wird formuliert?**
Eine verstärkte Reifung des präfrontalen Kortex, der eng mit den exekutiven Funktionen assoziiert ist.
- 5. Welche zwei Tests der exekutiven Funktionen wurden eingesetzt?**
Der D2-Test und der Stroop-Test.
- 6. Wie ist das Geschlechterverhältnis in schulbasierten ADHS-Studien?**
Etwa 2:1 (Jungen zu Mädchen); in klinischen Studien 5:1.
- 7. Was erfasst der Einbeinstand (30 s) auf der Kraftmessplatte?**
Die Auslenkung des Körperschwerpunkts, also Körperschwankung/Gleichgewicht.
- 8. Welche exekutiven Funktionen sind mit dem präfrontalen Kortex assoziiert?**
Inhibition, kognitive Flexibilität, Handlungsplanung und Aufmerksamkeit.
- 9. Wie definiert die ICD-11 (6A05) 'Impulsivität' bei ADHS?**
Als Tendenz, unmittelbar auf Reize zu reagieren, ohne die Risiken und Folgen abzuwägen oder zu berücksichtigen.
- 10. Welche drei Bereiche wurden im Pre-Post-Design der skate-aid-Studie erfasst?**
Kognition, Motorik und sozial-emotionale Befindlichkeit.

Prüfungsfragen (12)

1. Welches Mindestkriterium bezüglich der Dauer nennt die ICD-11 (6A05) für ADHS?

- a) Ein anhaltendes Muster von mindestens 6 Monaten ✓
- b) Ein anhaltendes Muster von mindestens 3 Wochen
- c) Ein anhaltendes Muster von mindestens 12 Monaten
- d) Ein anhaltendes Muster von mindestens 2 Jahren

Warum: Der Foliensatz nennt ausdrücklich mindestens 6 Monate; die übrigen Zeitangaben stehen nicht in der Datei.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

2. Wie wurden die Kinder und Jugendlichen für das skate-aid-Programm ausgewählt?

- a) Sie meldeten sich eigenständig über eine Online-Plattform an
- b) Sie wurden per Zufallsauswahl aus Schulklassen gezogen
- c) Sie wurden in der Praxis Dr. Dirksen & Franke behandelt und von den Ärzten vorgeschlagen ✓
- d) Sie wurden von Sportvereinen an das Projekt vermittelt

Warum: Die Auswahl erfolgte durch ärztlichen Vorschlag in der Praxis, nicht durch Selbstanmeldung, Zufall oder Vereine.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

3. Über welchen Wirkmechanismus wirkt Methylphenidat laut Foliensatz?

- a) Durch Ausschüttung von Serotonin im Hippocampus
- b) Durch Hemmung des Rücktransports von Dopamin und Noradrenalin ✓
- c) Durch Blockade der Acetylcholin-Rezeptoren im Kortex
- d) Durch verstärkten Abbau von Dopamin im Striatum

Warum: Der Foliensatz beschreibt eine Reuptake-Inhibition, nicht Serotoninausschüttung, Rezeptorblockade oder verstärkten Abbau.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

4. Was besagt die neurobiologische Hypothese zur Wirkung des Skatens?

- a) Eine verstärkte Reifung des präfrontalen Kortex ✓
- b) Eine dauerhafte Vergrößerung des Kleinhirnvolumens
- c) Eine Erhöhung der Nervenleitgeschwindigkeit im Rückenmark
- d) Eine Reduktion der grauen Substanz im Striatum

Warum: Der Foliensatz formuliert die Reifung des präfrontalen Kortex; die anderen Strukturen werden nicht genannt.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

5. Wie lang war die Skateboard-Intervention, deren Effekt Hypothese 2 prüft?

- a) 8 Wochen
- b) 16 Wochen ✓
- c) 24 Wochen
- d) 4 Wochen

Warum: Der Foliensatz spricht ausdrücklich von einer 16-wöchigen Intervention; die übrigen Zeiträume werden nicht genannt.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

6. Welche Prävalenz nennt der Foliensatz für ADHS bei Kindern im Grundschulalter?

- a) 3 % – 5 %
- b) 6,8 % – 15,1 % ✓
- c) 1 % – 2 %
- d) 20 % – 25 %

Warum: Die Folie unterscheidet schulpflichtiges Alter (3-5 %) und Grundschulalter (6,8-15,1 %); gefragt ist Letzteres.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

7. Wie ist das Verhältnis Jungen zu Mädchen in klinischen ADHS-Studien?

- a) 2 : 1
- b) 3 : 2
- c) 5 : 1 ✓**
- d) 1 : 1

Warum: Der Foliensatz gibt in klinischen Studien 5:1 an, während schulbasierte epidemiologische Studien 2:1 zeigen.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

8. In welcher Hirnstruktur wirkt Methylphenidat laut Foliensatz vor allem?

- a) Im Kleinhirn
- b) In der Amygdala
- c) Im Hippocampus
- d) Im Striatum ✓**

Warum: Die Folie zur Reuptake-Inhibition nennt die Wirkung vor allem im Striatum (Basalganglien).

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

9. Bis zu welchem Alter reift der präfrontale Kortex laut Foliensatz?

- a) Bis ca. zum 12. Lebensjahr
- b) Bis ca. zum 18. Lebensjahr
- c) Bis ca. zum 30. Lebensjahr ✓**
- d) Bis ca. zum 45. Lebensjahr

Warum: Der Foliensatz nennt eine Reifung bis ca. zum 30. Lebensjahr; die anderen Zeitpunkte stehen nicht im Text.

Beleg: Sitzung 04 (Bohn / skate-aid), Foliensatz

10. Welcher Anteil der Kinder zeigt laut Foliensatz anhaltende Symptome in der mittleren Kindheit und im frühen Jugendalter?

- a) 40 % – 50 %
- b) 59 % – 67 % ✓**
- c) 70 % – 80 %
- d) 30 % – 45 %

Warum: Der Foliensatz nennt ausdrücklich 59 %–67 %; die übrigen Bereiche stehen nicht im Text.

Beleg: Foliensatz Sitzung 04 ADHS/skate-aid (Bohn), Symptompersistenz mittlere Kindheit/frühes Jugendalter

11. Worauf wirken aerobe Aktivitäten laut Foliensatz positiv und damit auf die ADHS-Symptomatik?

- a) Auf die exekutiven Funktionen ✓**
- b) Auf die Reizleitung im Rückenmark
- c) Auf die Serotoninausschüttung im Hippocampus
- d) Auf das Kleinhirnvolumen

Warum: Der Foliensatz nennt die positive Wirkung auf die exekutiven Funktionen; die anderen Strukturen werden dazu nicht genannt.

Beleg: Foliensatz Sitzung 04 ADHS/skate-aid (Bohn), aerobe Aktivität und exekutive Funktionen

12. Was besagt Hypothese 1 der skate-aid-Studie?

- a) Die Skateboard-Intervention verbessert die Kognition stärker als die Motorik der Kinder
- b) Aerobe Aktivität ersetzt bei ADHS langfristig die Gabe von Methylphenidat vollständig
- c) Die Reifung des präfrontalen Kortex ist bei ADHS bereits mit 18 Jahren abgeschlossen

d) Kinder mit ADHS schneiden in motorischen und kognitiven Tests schlechter ab als die Kontrollgruppe ✓

Warum: Hypothese 1 vergleicht Kinder mit vs. ohne ADHS in Motorik/Kognition; die übrigen Aussagen betreffen Hypothese 2 bzw. stehen so nicht im Text.

Beleg: Foliensatz Sitzung 04 ADHS/skate-aid (Bohn), Hypothese 1 Kinder mit vs. ohne ADHS

Sitzung 05 — Kognition & Bewegung im Alter

21.05 • Voelcker-Rehage

Zusammenfassung

Kognition und Bewegung im Alter: Inklusion im vs. durch Sport, kognitives Altern, Trainingseffekte, Immobilität in der Pflege.

Die Vorlesung unterscheidet 'Inklusion im Sport' (Teilhabe Älterer/Menschen mit Behinderung an Sportangeboten selbst) und 'Inklusion durch Sport' (Sport als Mittel, damit sich alltägliches Leben, Wohlbefinden und Selbstständigkeit Älterer verbessern). Inklusion bedeutet, das System so zu verändern, dass alle Teil des Ganzen werden, während Integration lediglich das Eingliedern in ein bestehendes System meint. Deutschland altert: Seit 1990 hat sich die Zahl der Menschen ab 65 Jahren um 42% erhöht, und 2060 wird jede dritte Person 65 Jahre und älter sein. Daraus ergibt sich die wachsende Relevanz der Inklusion Älterer im und durch Sport. Kognitive Funktionen verändern sich im Alter unterschiedlich: Die fluide Intelligenz (Geschwindigkeit, Flexibilität, Mehrfachaufgaben) nimmt ab, während die kristalline Intelligenz (Wissen, gezieltere Informationsauswahl) länger stabil bleibt. Das Gehirn ist dabei nicht starr, sondern plastisch. Körperliche Aktivität wirkt auf das Gehirn und gilt als Schutzfaktor gegen dementielle Erkrankungen. Kombiniertes körperlich-kognitives Training bzw. Ausdauer- plus Koordinations-/Kognitionstraining scheint zur Förderung der Kognition am effektivsten; besonders Kinder und Ältere profitieren. In der stationären Pflege zeigt sich ein Teufelskreis aus Immobilität und sinkender körperlicher wie kognitiver Leistungsfähigkeit. Pflegeheimbewohner gehen im Mittel nur ca. 1007 Schritte pro Tag und verbringen über 9 Stunden sitzend; Modellprojekte wie PROCARE und PROGRESS setzen als Primärprävention an.

Karteikarten (12)

1. Unterschied 'Inklusion im Sport' vs. 'Inklusion durch Sport'?

'Im Sport' = Teilhabe an den Sportangeboten selbst. 'Durch Sport' = Sport als Mittel, um Alltag, Wohlbefinden und Selbstständigkeit Älterer zu verbessern.

2. Wie unterscheiden sich Integration und Inklusion?

Integration = Eingliederung in ein bestehendes System. Inklusion = das System wird so verändert, dass alle Teil des Ganzen werden.

3. Wie verändern sich fluide und kristalline Intelligenz im Alter?

Fluide Intelligenz (Geschwindigkeit, Flexibilität) nimmt ab; kristalline Intelligenz (Wissen) bleibt länger stabil.

4. Welche Trainingsform scheint zur Förderung der Kognition am effektivsten?

Kombiniertes körperlich-kognitives Training bzw. Ausdauer- plus Koordinations-/Kognitionstraining.

5. Wie viele Schritte gehen Pflegeheimbewohner im Mittel pro Tag?

Ca. 1007 Schritte pro Tag, bei über 9 Stunden Sitzzeit.

6. Welche Folgen hat 'Nicht-Inklusion' Älterer?

U.a. soziale Isolation, Verlust von Autonomie/Mobilität, Beeinträchtigung psychischer Gesundheit und Kognition, Stigmatisierung, Probleme bei der Alltagsbewältigung.

7. Wie ist das PROCARE-Training zeitlich strukturiert?

16 Wochen, 2x pro Woche, je 45 Minuten.

8. Welches Medikament nennt der Foliensatz zur Parkinson-Behandlung?

Levodopa (L-Dopa).

9. Beispiel für anpassbare Inklusion im Sport?

Volleyball kann im Sitzen gespielt werden.

10. Womit ist ein geringerer Aktivitätsradius assoziiert (Polku et al. 2015)?

Mit einer höheren Prävalenz depressiver Symptome.

11. In welchen Bereichen profitieren laut Foliensatz besonders Kinder (Hillman 2008) und Ältere (Colcombe 2003) von körperlicher Aktivität?

Kinder: mathematische und Lesefertigkeiten; Ältere: fluide kognitive Funktionen.

12. Welche Mechanismen unterscheiden Ausdauer- von Koordinations-/motorischem Training?

Ausdauertraining: Angiogenese und Neurogenese (Hippocampus). Koordinations-/motorisches Training: Synaptogenese, Myelinisation, Dendritenwachstum. BDNF (Nervenzwachstumsfaktoren) werden bei beiden gefördert.

Prüfungsfragen (15)

1. Was beschreibt 'Inklusion durch Sport' (im Gegensatz zu 'Inklusion im Sport')?

a) Sport wird genutzt, um Alltag, Wohlbefinden und Selbstständigkeit Älterer zu verbessern ✓

b) Ältere nehmen an bestehenden kompetitiven Wettkämpfen teil

c) Das Sportsystem wird ausschließlich für Menschen mit Behinderung reserviert

d) Ältere werden in ein unverändertes Sportsystem eingegliedert

Warum: 'Durch Sport' meint Sport als Mittel zur Verbesserung des Lebens Älterer; die anderen Optionen beschreiben Wettkampf, eine falsche Reservierung oder Integration.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

2. Wie wird 'Inklusion' von 'Integration' abgegrenzt?

a) Integration verändert das System, Inklusion gliedert Menschen ein

b) Bei Inklusion wird das System so verändert, dass alle Teil des Ganzen werden ✓

c) Inklusion und Integration bezeichnen exakt denselben Vorgang

d) Inklusion meint das Eingliedern in ein bestehendes, unverändertes System

Warum: Nur Option 2 gibt die Definition korrekt wieder; die übrigen vertauschen die Begriffe oder setzen sie gleich.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

3. Welche Aussage zur Bevölkerungsentwicklung nennt der Foliensatz?

a) Die Zahl der über 65-Jährigen ist seit 1990 um 42% gesunken

b) 2060 wird jede zehnte Person 65 Jahre und älter sein

c) 2060 wird jede dritte Person 65 Jahre und älter sein ✓

d) Der Anteil Älterer bleibt bis 2060 nahezu konstant

Warum: Der Foliensatz nennt +42% seit 1990 und für 2060 jede dritte Person ab 65; die anderen Optionen widersprechen dem.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

4. Wie verändern sich fluide und kristalline Intelligenz im Altersverlauf?

a) Beide nehmen im Alter gleichermaßen stark ab

b) Die kristalline nimmt ab, die fluide bleibt stabil

c) Beide nehmen im Alter kontinuierlich zu

d) Die fluide nimmt ab, die kristalline bleibt länger stabil ✓

Warum: Geschwindigkeit/Flexibilität gehören zur fluiden (abnehmenden), Wissen zur kristallinen (stabileren) Intelligenz; die anderen Optionen kehren dies um.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

5. Welche Trainingsform gilt zur Förderung der Kognition als am effektivsten?

a) Reines Krafttraining ohne kognitive Anteile

b) Kombiniertes körperlich-kognitives bzw. Ausdauer- plus Koordinationstraining ✓

- c) Ausschließlich passive Mobilisation im Sitzen
- d) Reines Dehn- und Stretchingtraining

Warum: Der Foliensatz benennt die Kombination körperlich-kognitiv als am effektivsten; die anderen greifen nur einen unzureichenden Einzelaspekt heraus.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

6. Welche Angabe zur Aktivität von Pflegeheimbewohnern macht der Foliensatz?

a) Sie gehen im Mittel nur ca. 1007 Schritte pro Tag und sitzen über 9 Stunden ✓

- b) Sie gehen im Mittel über 10.000 Schritte pro Tag
- c) Sie verbringen im Mittel nur etwa 1 Stunde pro Tag sitzend
- d) Sie legen im Mittel täglich einen Aktivitätsradius bis zur Stadt zurück

Warum: Der Foliensatz nennt ca. 1007 Schritte und über 9 Stunden Sitzzeit; die anderen Optionen widersprechen diesen Werten.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

7. Was bezeichnet 'Freezing of Gait' laut Foliensatz?

- a) Ein Kraftverlust der Beinmuskulatur im Alter
- b) Ein Symptom der Parkinson-Erkrankung ✓**
- c) Eine Muskelverspannung nach dem Sport
- d) Einen Rückgang der grauen Hirnsubstanz

Warum: 'Freezing of Gait' wird als eines der einschränkendsten Symptome der Parkinson-Erkrankung angeführt.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

8. Welchen Zusammenhang zeigt Iso-Markku et al. (2022) laut Foliensatz?

- a) Krafttraining erhöht das Demenzrisiko im Alter
- b) Nur Koordinationstraining senkt das Demenzrisiko
- c) Aktivität wirkt erst ab dem 80. Lebensjahr schützend
- d) Aktivität in der Lebensmitte schützt vor Demenz ✓**

Warum: Genannt wird körperliche Aktivität in der Lebensmitte als Schutzfaktor gegen dementielle Erkrankungen.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

9. Welche strukturelle Veränderung der Gehirnalterung nennt der Foliensatz?

- a) Zunahme der flüssigkeitsgefüllten Hohlräume ✓**
- b) Zunahme der grauen Substanz
- c) Zunahme der weißen Substanz
- d) Zunahme der Nervenbahnen im Hippocampus

Warum: Genannt werden Abnahme weißer und grauer Substanz sowie Zunahme flüssigkeitsgefüllter Hohlräume.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

10. Welcher Mechanismus wird dem Training zugeschrieben?

- a) Abbau von Nervenwachstumsfaktoren
- b) Rückgang der Synaptogenese
- c) Neurogenese im Hippocampus ✓**
- d) Abnahme der Angiogenese

Warum: Genannt wird u.a. Neurogenese im Hippocampus als trainingsbedingter Mechanismus; die anderen sind deren Gegenteil.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

11. Wo ist Inklusion laut Foliensatz besonders problematisch?

- a) Im Gesundheitssport für Ältere

b) Im kompetitiven Breitensport ✓

- c) Beim angepassten Sitzvolleyball
- d) In differenzierten Turngruppen

Warum: Problematisch ist der kompetitive Breitensport (Gewinnen/Verlieren, Auf-/Abstieg); die anderen sind gerade Beispiele gelingender Anpassung.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

12. Wie beschreibt Jansen et al. (2017) den Aktivitätsradius von Pflegeheimbewohnenden?

- a) Überwiegend außerhalb der Einrichtung
- b) Gleichmäßig über alle Lebensräume verteilt
- c) Ausgedehnt bis auf die Stadt
- d) Zu ca. 90 % auf Zimmer und Wohnfläche beschränkt ✓**

Warum: Der Radius ist zu ca. 90 % auf Zimmer/Wohnfläche beschränkt; die anderen Optionen widersprechen dem.

Beleg: Sitzung 05 (Voelcker-Rehage), Foliensatz

13. Welchen Effekt körperlicher Aktivität zeigte Colcombe et al. (2003) laut Foliensatz speziell für Ältere?

- a) Eine Zunahme der kristallinen Intelligenz
- b) Verbesserte mathematische und Lesefertigkeiten
- c) Verbesserte fluide kognitive Funktionen ✓**
- d) Einen Rückgang der grauen Substanz

Warum: Colcombe (2003) zeigte bei Älteren verbesserte fluide kognitive Funktionen; mathematische/Lesefertigkeiten betreffen Kinder (Hillman 2008) und die übrigen Optionen gehören zu anderen Folien.

Beleg: Foliensatz Sitzung 05 Kognition & Bewegung im Alter (Voelcker-Rehage), Besonders Kinder und Ältere profitieren (Colcombe 2003)

14. Welcher Mechanismus wird im Foliensatz speziell dem motorischen/Koordinationstraining (und nicht dem Ausdauertraining) zugeordnet?

- a) Synaptogenese und Myelinisation ✓**
- b) Angiogenese der Blutgefäße
- c) Neurogenese im Hippocampus
- d) BDNF-Ausschüttung bei beiden Formen

Warum: Synaptogenese, Myelinisation und Dendritenwachstum werden dem motorischen Training zugeordnet, während Angiogenese und Neurogenese dem Ausdauertraining zugeschrieben werden und BDNF bei beiden gefördert wird.

Beleg: Foliensatz Sitzung 05 Kognition & Bewegung im Alter (Voelcker-Rehage), Dem Training zugrunde liegende Mechanismen (Ausdauer- vs. Koordinationstraining)

15. Wodurch erweitert das Modellprojekt PROGRESS das PROCARE-Konzept in der stationären Pflege?

- a) Durch eine Verkürzung des Trainings auf nur 8 Wochen
- b) Durch eine Umgebungs- bzw. Verhältnisprävention (Poster, Outdoor-Routen) ✓**
- c) Durch ausschließlich kognitives Training per Tablet
- d) Durch den vollständigen Verzicht auf Gruppentraining

Warum: PROGRESS ergänzt PROCARE um eine Verhältnisprävention der Umgebung (Poster, Outdoor-Routen, Change of location 150-360m); die übrigen Optionen widersprechen dem Foliensatz.

Beleg: Foliensatz Sitzung 05 Kognition & Bewegung im Alter (Voelcker-Rehage), PROGRESS / Verhältnisprävention

Sitzung 06 — Fachdidaktische Ansätze für heterogene Lerngruppen

11.06 · Leineweber

Zusammenfassung

Fachdidaktik für heterogene Lerngruppen: Heterogenität als Konstrukt, Drei-Ebenen-Modell, erziehender Schulsport, TREE / 6+1.

Inklusiver Unterricht meint das Recht aller Schülerinnen und Schüler, unabhängig von Fähigkeiten, Beeinträchtigungen oder ethnischer, kultureller und sozialer Herkunft, in 'einer Schule für alle' miteinander und voneinander zu lernen; der inklusive Blick verschiebt die Perspektive vom Kind als Problem hin zum Bildungssystem als Problem. Heterogenität ist ein zugeschriebenes Konstrukt, das beim Vergleich von Personengruppen bezüglich einer bestimmten Kategorie entsteht; sie ist kategorien- und standortabhängig, und die unterschiedenen Gruppen gelten bezüglich der Unterscheidungskategorie wiederum als homogen. Die inklusive Didaktik wird über das Drei-Ebenen-Modell (Scheid & Friedrich) strukturiert: Ziel-Ebene (Kernlehrplan, Kompetenzen, Standards, Index), Konstrukt-Ebene (didaktische Konstruktionsprinzipien, Modelle, Stellschrauben) und Unterrichtsebene (konkrete Planung mit individuellen Anpassungen). Der erziehende Schulsport eignet sich für inklusiven Unterricht: auf Zielebene über Doppelauftrag und Handlungskompetenz, auf Inhaltsebene über die 9 Bewegungsfelder/Sportbereiche und auf Methodenebene über die drei Vermittlungsprinzipien Mehrperspektivität, Reflexion sowie Verständigung und Partizipation. Das TREE-Modell (Australian Sports Commission) benennt vier Stellschrauben zur Anpassung: Teaching Style, Rules/Regulations, Environment und Equipment; das '6+1 Modell' (Tiemann, 2015) erweitert es und misst der Lehrkraft und ihrer Haltung hohe Bedeutung bei.

Karteikarten (11)

1. Wofür stehen die vier Buchstaben des TREE-Modells?

Teaching Style, Rules/Regulations, Environment und Equipment – vier Stellschrauben zur Anpassung des Sportunterrichts.

2. Was kennzeichnet das '6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts' (Tiemann, 2015)?

Es modifiziert und erweitert das TREE-Modell und misst der Lehrkraft und ihrer Haltung hohe Bedeutung bei.

3. Was ist die Grundannahme der reflexiven Koedukation?

Formale Chancengleichheit ist nicht gleich echter Chancengerechtigkeit; Ziel ist ein bewusster, reflexiver Umgang mit der Differenzkategorie Geschlecht.

4. Was meint 'Dramatisierung vs. Entdramatisierung'?

Unterschiede werden nicht 'weggeredet', sondern teils bewusst zum Thema gemacht (Dramatisierung), teils wird das Gemeinsame sichtbar gemacht (Entdramatisierung).

5. Welche drei Vermittlungsprinzipien nennt der erziehende Schulsport?

Mehrperspektivität, Reflexion sowie Verständigung und Partizipation.

6. Nenne didaktische Leitideen zum Umgang mit Fremdheit (Gieß-Stüber, 2005).

Begegnung mit dem Fremden, Selbstrelativierung (eigener Ethnozentrismus), Differenzierung der Wahrnehmung und Ent-Differenzierung (transkulturelle Elemente).

7. Was umfasst die Konstrukt-Ebene im Drei-Ebenen-Modell?

Didaktische Konstruktionsprinzipien: didaktische Modelle und Stellschrauben.

8. Was meint 'Ent-Differenzierung' im interkulturellen Lernen?

Erkennen transkultureller/universeller Elemente von Kultur, z.B. im Sport.

9. Was kennzeichnet koexistente Lernsituationen (Weichert)?

Partner haben eigene Bewegungsaufgaben; der soziale Austausch ist nachrangig.

10. Was besagt der 'Implikationszusammenhang' der pädagogischen Vermittlungsprinzipien?

Die Vermittlungsprinzipien (Mehrperspektivität, Reflexion, Verständigung und Partizipation) sind aufeinander bezogen und stehen in wechselseitiger Abhängigkeit.

11. Was meint die 'reflexive Haltung' als Aspekt der reflexiven Koedukation?

Lehrerseitig die kritische Durchleuchtung pädagogischer Gestaltungen, schülerseitig der bewusste Umgang mit der Differenzkategorie Geschlecht – kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Verhältnissen und Veränderungsmöglichkeiten.

Prüfungsfragen (15)**1. Wie wird Heterogenität nach Wenning (2007) definiert?**

- a) Als objektiv messbare Eigenschaft einzelner Personen unabhängig vom Kontext
- b) Als zugeschriebenes Konstrukt, das beim Vergleich von Personengruppen bezüglich einer Kategorie entsteht ✓**
- c) Als medizinische Kategorie zur Einteilung nach Förderbedarf
- d) Als dauerhafter Zustand der Verschiedenheit, der sich pädagogisch nicht auflösen lässt

Warum: Heterogenität ist ein zugeschriebenes, kategorien- und standortabhängiges Konstrukt und gerade nicht objektiv-messbar, medizinisch oder unveränderlich.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

2. Welche drei Ebenen umfasst das Drei-Ebenen-Modell (Scheid & Friedrich)?

- a) Motorik-Ebene, Kognitions-Ebene und Sozial-Ebene
- b) Individual-Ebene, Gruppen-Ebene und System-Ebene
- c) Ziel-Ebene, Konstrukt-Ebene und Unterrichtsebene ✓**
- d) Planungs-Ebene, Durchführungs-Ebene und Reflexions-Ebene

Warum: Das Modell nennt ausdrücklich Ziel-, Konstrukt- und Unterrichtsebene; die anderen Gliederungen kommen nicht vor.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

3. Welche drei Vermittlungsprinzipien nennt der erziehende Schulsport auf der Methodenebene?

- a) Mehrperspektivität, Reflexion sowie Verständigung und Partizipation ✓**
- b) Differenzierung, Individualisierung und Kompetenzorientierung
- c) Teaching Style, Environment und Equipment
- d) Begegnung, Selbstrelativierung und Anerkennung

Warum: Nur Option 1 nennt die drei Prinzipien des erziehenden Schulsports; die übrigen gehören zu anderen Modellen (TREE, interkulturelles Lernen).

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

4. Was kennzeichnet das 6+1 Modell eines adaptiven Sportunterrichts (Tiemann, 2015)?

- a) Es ersetzt das TREE-Modell durch ein völlig neues, unabhängiges Konzept
- b) Es reduziert die Bedeutung der Lehrkraft zugunsten reiner Materialanpassung
- c) Es erweitert das TREE-Modell und betont die Haltung der Lehrkraft ✓**
- d) Es beschränkt sich auf die Anpassung von Regeln und Wettkampfformen

Warum: Das 6+1 Modell erweitert TREE und hebt die Bedeutung der Lehrkraft hervor, statt es zu ersetzen oder die Lehrkraft zurückzustellen.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

5. Welche Aussage gehört zur Grundannahme der reflexiven Koedukation?

- a) Geschlecht sollte im Unterricht möglichst unthematisiert bleiben
- b) Formale Chancengleichheit ist nicht gleichbedeutend mit echter Chancengerechtigkeit ✓**
- c) Mädchen und Jungen sollten grundsätzlich getrennt unterrichtet werden

d) Kulturelle Fremdheit ist die zentrale Differenzkategorie des Ansatzes

Warum: Grundannahme ist, dass formale Chancengleichheit nicht echter Chancengerechtigkeit entspricht; reflexive Koedukation thematisiert Geschlecht bewusst und stellt nicht Fremdheit ins Zentrum.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

6. Wofür steht das 'E' für Environment im TREE-Modell?

- a) Für die Anpassung der Bewertungskriterien
- b) Für die Gestaltung/Anpassung der Umgebung und des Raums ✓**
- c) Für die Auswahl der Lehrkraft
- d) Für die emotionale Beziehung in der Gruppe

Warum: Environment meint die Umgebung/den Raum; Bewertung, Lehrkraft-Auswahl und Beziehung sind nicht mit diesem Buchstaben gemeint.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

7. Was ist der 'Index für Inklusion' (Boban & Hinz, 2003) laut Foliensatz?

- a) Ein Instrument zur inklusiven Schul- und Unterrichtsentwicklung ✓**
- b) Ein Diagnoseverfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs
- c) Ein verbindlicher Kernlehrplan für den Sportunterricht
- d) Ein Klassifikationsverfahren für Behinderungsformen im Sport

Warum: Der Index wird als Instrument zur inklusiven Schul- und Unterrichtsentwicklung eingeführt; die anderen sind themennahe Fehlzuordnungen.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

8. Wofür steht das 'R' im TREE-Modell?

- a) Roles – Rollenverteilung im Team
- b) Rules/Regulations – Anpassung der Regeln ✓**
- c) Resources – Materialausstattung
- d) Routines – wiederkehrende Bewegungsabläufe

Warum: Im TREE-Modell steht R für Rules/Regulations; die übrigen R-Begriffe werden im Modell nicht so benannt.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

9. Was ist das Ziel des Ansatzes 'Bewegungsbeziehungen' (Weichert)?

- a) Die Steigerung der individuellen motorischen Leistung im Wettkampf
- b) Die Vermittlung normierter Bewegungstechniken nach Altersstufen
- c) Der Aufbau dichter Bewegungsbeziehungen durch Passung von Person und Sache ✓**
- d) Die Einteilung von Lerngruppen nach ihrem Leistungsniveau

Warum: Weichert zielt auf dichte Bewegungsbeziehungen und die Passung Person-Sache, nicht auf Leistung, Normtechnik oder Selektion.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

10. Welche Stufe liegt vor, wenn das gemeinsame Ziel nur durch Zusammenarbeit erreichbar ist?

- a) Komplementäre Lernsituationen
- b) Koexistente Lernsituationen
- c) Subsidiäre Lernsituationen
- d) Solidarische Lernsituationen ✓**

Warum: Solidarische Lernsituationen setzen ein nur gemeinsam erreichbares Ziel voraus; koexistente/komplementäre unterscheiden sich davon.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

11. Welche Leitidee meint das 'Erkennen des eigenen Ethnozentrismus' (Gieß-Stüber)?

- a) Begegnung mit dem Fremden
- b) Selbstrelativierung ✓**
- c) Ent-Differenzierung

d) Erfahrung von Zugehörigkeit

Warum: Selbstrelativierung bezeichnet das Erkennen der eigenen Kultur als eine unter vielen; die anderen betreffen Dialog bzw. transkulturelle Elemente.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

12. Was meint 'Dramatisierung versus Entdramatisierung' in der reflexiven Koedukation?

a) Das bewusste Betonen oder Zurückstellen von Differenzen ✓

b) Die strikte Geschlechtertrennung in allen Phasen

c) Die Bewertung nach getrennten Leistungsmaßstäben

d) Den vollständigen Verzicht auf jede Thematisierung

Warum: Gemeint ist das 'Spiel mit Stereotypen': Unterschiede mal betonen, mal das Gemeinsame sichtbar machen – kein Trennen oder Wegreden.

Beleg: Sitzung 06 (Leineweber), Foliensatz

13. Was ordnet der erziehende Schulsport der Zielebene zu?

a) Die neun Bewegungsfelder und Sportbereiche des Schulsports

b) Die drei pädagogischen Vermittlungsprinzipien der Methodenebene

c) Den Doppelauftrag des Schulsports und die übergreifende fachliche Handlungskompetenz ✓

d) Die Passung zwischen Person und Sache nach Weichert

Warum: Die neun Bewegungsfelder gehören zur Inhaltsebene, die Vermittlungsprinzipien zur Methodenebene und die Passung Person-Sache zum Ansatz der Bewegungsbeziehungen.

Beleg: Foliensatz Sitzung 06 Fachdidaktische Ansätze (Leineweber), Zielebene/Doppelauftrag

14. Wodurch sind subsidiäre Lernsituationen (Weichert, 2008) gekennzeichnet?

a) Partner A unterstützt Partner B (prosozial bzw. unterstützend) ✓

b) Partner haben jeweils eigene Bewegungsaufgaben, sozialer Austausch ist nachrangig

c) Inhaltliche Aspekte treten zugunsten der Kommunikation in den Hintergrund

d) Das gemeinsame Handlungsziel kann nur durch Zusammenarbeit erreicht werden

Warum: Die übrigen Beschreibungen kennzeichnen koexistente, kommunikative bzw. kooperative/solidarische Lernsituationen und nicht die subsidiäre Stufe.

Beleg: Foliensatz Sitzung 06 Fachdidaktische Ansätze (Leineweber), subsidiäre Lernsituationen

15. Welche Leitidee zum Umgang mit Fremdheit (Gieß-Stüber) meint das Aushandeln von Zielen, Regeln und Lösungswegen bei Konflikten?

a) Anerkennung und Wertschätzung

b) Erfahrung von Zugehörigkeit

c) Fähigkeit zum Aushandeln / Konfliktfähigkeit ✓

d) Wahrnehmung und Überschreitung von Grenzen

Warum: Anerkennung meint gemeinsame Beiträge, Zugehörigkeit das Wir-Gefühl und Grenzüberschreitung das Einlassen auf Fremdes – nur die Konfliktfähigkeit betrifft das Aushandeln.

Beleg: Foliensatz Sitzung 06 Fachdidaktische Ansätze (Leineweber), Leitideen Umgang mit Fremdheit

Sitzung 07 — Blindenfußball in der Schule

18.06 · Winnebeck

Zusammenfassung

Blindenfußball in der Schule — mit Praxisbezug aus der Nationalmannschaft. Bildlastige Sitzung, entsprechend wenige gesicherte Fakten.

Die Sitzung 07 zum Thema 'Blindenfußball (in der Schule)' wird von zwei Referenten mit Praxisbezug gestaltet: Jonas Fuhrmann, ehemaliger Blindenfußball-Nationalspieler, und Leon Winnebeck, Co-Trainer und Hintertorguide der Blindenfußball-Nationalmannschaft. Der Foliensatz rahmt Blindenfußball in der Schule über zentrale pädagogische Leitbegriffe: Heterogenität, Vertrauen, Soziales Lernen, Kooperation, Leistung, Inklusion und Teilhabe.

Karteikarten (6)

1. **Welche Rolle hat Leon Winnebeck in der Blindenfußball-Nationalmannschaft?**
Co-Trainer und Hintertorguide der Nationalmannschaft.
2. **Welche pädagogischen Leitbegriffe rahmen den Foliensatz zu Blindenfußball in der Schule?**
Heterogenität, Vertrauen, Soziales Lernen, Kooperation, Leistung, Inklusion und Teilhabe.
3. **Wodurch ist der Blindenfußball für die Spieler ortbar?**
Im Ball sind Rasseln bzw. Klangelemente eingebaut, sodass er beim Rollen hörbar ist.
4. **Welche drei Orientierungs-/Rufhelfer leiten die Feldspieler akustisch über das Feld?**
Der (sehende) Torwart für die eigene Abwehrzone, der Trainer/Guide im Mittelfeld und der Hintertorguide hinter dem gegnerischen Tor.
5. **Wie lang ist die reguläre Spielzeit im Blindenfußball-Kleinfeldregelwerk?**
Zweimal 20 Minuten (2 x 20 min).
6. **Darf der Torwart im B1-Blindenfußball sehen?**
Ja, der Torwart ist sehend (oder sehbehindert) und agiert in einem begrenzten Torraum; er unterstützt die Feldspieler mit Ansagen.

Prüfungsfragen (6)

1. **Welche Funktion übt Leon Winnebeck laut Foliensatz in der Blindenfußball-Nationalmannschaft aus?**

- a) **Co-Trainer und Hintertorguide der Nationalmannschaft** ✓
- b) Ehemaliger Blindenfußball-Nationalspieler
- c) Schiedsrichter der Nationalmannschaft
- d) Physiotherapeut der Nationalmannschaft

Warum: Der ehemalige Nationalspieler ist Jonas Fuhrmann; Schiedsrichter- oder Physiotherapeutenrollen werden nicht genannt.

Beleg: Sitzung 07 (Winnebeck), Folie 2

2. **Welcher Begriff wird im Foliensatz NICHT als pädagogischer Leitbegriff aufgeführt?**

- a) **Wettkampforientierung** ✓
- b) Vertrauen
- c) Soziales Lernen
- d) Kooperation

Warum: Vertrauen, Soziales Lernen und Kooperation stehen explizit auf den Folien, 'Wettkampforientierung' hingegen nicht.

Beleg: Sitzung 07 (Winnebeck), Folie 13

3. **Wie ist eine Blindenfußball-Mannschaft (B1) auf dem Feld regulär besetzt?**

a) **4 blinde Feldspieler und 1 sehender Torwart** ✓

b) 5 blinde Feldspieler ohne Torwart

c) 6 blinde Feldspieler und 1 blinder Torwart

d) 3 blinde Feldspieler und 2 sehende Torhüter

Warum: Das Regelwerk sieht genau vier blinde Feldspieler plus einen sehenden (oder sehbehinderten) Torwart vor, nicht fünf, sechs oder drei Feldspieler.

Beleg: IBSA-/DBS-Blindenfußball-Regelwerk (allgemein, nicht Foliensatz), Teamgröße/Torwart

4. Warum tragen im B1-Blindenfußball alle Feldspieler zusätzlich zur Augenbinde noch lichtundurchlässige Augenpflaster?

a) **Um Chancengleichheit trotz möglicher Restsehkraft herzustellen** ✓

b) Um Verletzungen der Augen beim Kopfball zu vermeiden

c) Um die Spieler optisch als Team erkennbar zu machen

d) Um Blendung durch Flutlicht zu reduzieren

Warum: Die Augenpflaster unter der Binde sichern gleiche Bedingungen für alle, da B1-Spieler unterschiedliche Restsehkraft haben können; Schutz-, Erkennungs- oder Blendungsgründe sind nicht der Zweck.

Beleg: IBSA-/DBS-Blindenfußball-Regelwerk (allgemein, nicht Foliensatz), Augenklasse B1/Chancengleichheit

5. Welches Wort muss ein Spieler beim Anlaufen auf einen ballführenden Gegner rufen?

a) Ole!

b) Stop!

c) **Voy!** ✓

d) Ball!

Warum: Vorgeschrieben ist der spanische Zuruf 'Voy!' ('ich komme'), der den Gegner vor dem Zweikampf warnt; die anderen Rufe sind im Regelwerk nicht als Pflichtansage vorgesehen.

Beleg: IBSA-/DBS-Blindenfußball-Regelwerk (allgemein, nicht Foliensatz), Zuruf 'Voy!'

6. Welche Funktion haben die festen Banden an den Seitenlinien im Blindenfußball?

a) Sie dienen als Torbegrenzung für das kleine Tor

b) **Sie halten den Ball im Spiel, sodass es kein Seiten-Aus gibt** ✓

c) Sie markieren die Auswechselzone der Betreuer

d) Sie trennen die Zuschauer akustisch vom Spielfeld

Warum: Die Banden halten den Ball im Spiel und ersetzen das Seiten-Aus, sie sind weder Torbegrenzung noch Auswechsel- oder Zuschauerabtrennung.

Beleg: IBSA-/DBS-Blindenfußball-Regelwerk (allgemein, nicht Foliensatz), Bandensystem/Seitenlinie

Sitzung 08 — Sport mit krebskranken Kindern

25.06 • Boll

Zusammenfassung

(Natur-)Sport mit onkologisch erkrankten Kindern: Nachsorge-Angebot, Zieldimensionen des Sports, Versorgungslage, Take-home-Message.

Das Projekt 'Natursport in der pädiatrischen Onkologie' ist ein natursportliches Nachsorgeangebot (Schneesport, Wassersport, Klettern/Bouldern) für onkologisch erkrankte Kinder und Jugendliche und ihre Familien im Sinne der familienorientierten Rehabilitation, seit Wintersemester 2021-22 am Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster und am UK Münster. Ziele des Sporttreibens werden in mehreren Dimensionen betrachtet: sportmotorische, affektive, kognitive und ästhetische Ziele sowie soziale und ethische Erziehungsstile; leitend ist der Gedanke 'Sport für Alle' mit Entfaltung von Fähigkeiten, Stärkung des Selbstvertrauens und (Wieder-)Eingliederung. Onkologisch erkrankte Kinder zeigen häufig fehlendes Bewegungsverhalten (durch Nebenwirkungen, fehlende Anreize, fehlende Bewegungsräume, Unsicherheiten, Rückzugverhalten), während körperliche Aktivität positive Effekte auf physische Leistungsfähigkeit, Fatigue und Lebensqualität hat. Die sportpädagogisch-sporttherapeutische Versorgung ist in Deutschland lückenhaft: Nur an 25 Kliniken (42%) gibt es Bewegungs- und Sportprogramme während der Akuttherapie und nur in 17 Kliniken (28%) Angebote in der Nachsorge (Gauß & Götte, 2021). Die Take-home-Message betont, das Potential der Gruppe zu nutzen, Potentiale über Limitierungen zu stellen und Heterogenität produktiv zu nutzen; Sport gilt als ideales Feld, um Teilhabe zu leben und zu erlernen ('Inklusion heißt: Vielfalt willkommen heißen').

Karteikarten (9)

- 1. Welche Sportarten umfasst das Angebot 'Natursport in der pädiatrischen Onkologie'?**
Schneesport, Wassersport sowie Klettern/Bouldern – als natursportliches Nachsorgeangebot.
- 2. Welche Zieldimensionen des Sporttreibens werden genannt?**
Sportmotorische, affektive, kognitive und ästhetische Ziele sowie soziale und ethische Erziehungsstile.
- 3. Ab welcher Dauer gilt ein Mensch nach SGB IX als behindert?**
Wenn körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate vom alterstypischen Zustand abweichen und die Teilhabe beeinträchtigt ist.
- 4. Welche Effekte hat körperliche Aktivität bei onkologisch erkrankten Kindern?**
Positive Effekte auf physische Leistungsfähigkeit (Ausdauer, Kraft, Motorik), Fatigue und Lebensqualität.
- 5. Was besagt die Take-home-Message zum Umgang mit Heterogenität?**
Heterogenität akzeptieren und produktiv nutzen; Potentiale über Limitierungen stellen; Sport ist ideales Feld, um Teilhabe zu leben und zu erlernen.
- 6. Seit wann läuft das Projekt Natursport in der pädiatrischen Onkologie?**
Neukonzeption seit Wintersemester 2021-22 (IfS Münster + UK Münster).
- 7. Was bedeutet 'Adaptive Skiing'?**
Skifahren für Menschen mit Behinderungen, mit oder ohne spezialisiertes Equipment.
- 8. Für wen ist das Nachsorgeangebot 'Natursport in der pädiatrischen Onkologie' konzipiert?**
Als natursportliches Nachsorgeangebot für onkologisch erkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien – im Sinne der familienorientierten Rehabilitation.

9. Welche Aktivitäts-Kennzahlen nennt der Foliensatz für 2022–2024 (Schnee/Wasser/Kletterwand)?

40 Tage im Schnee, 17 Tage auf dem Wasser und 24 Stunden an der Kletterwand.

Prüfungsfragen (12)

1. Welche Angabe zur klinischen Versorgungslage nennt der Foliensatz?

- a) **Nur an 25 Kliniken (42%) gibt es Sportprogramme während der Akuttherapie ✓**
- b) An allen Kliniken bestehen flächendeckende Nachsorgeangebote
- c) Angebote gibt es nur in der Reha, nie in der Akuttherapie
- d) Sportprogramme sind in Deutschland gesetzlich verpflichtend

Warum: Die anderen Optionen widersprechen den Folienszahlen (42% Akut, 28% Nachsorge) bzw. werden nicht behauptet.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

2. Welches Ziel wird dem Projekt 'Natursport in der pädiatrischen Onkologie' zugeordnet?

- a) Ausschließlich Leistungssport zur Wettkampfvorbereitung
- b) Rein medizinische Diagnostik ohne sportliche Inhalte
- c) **Erhalt körperlicher Leistungsfähigkeit und Rückkehr in den (Sport-)Alltag ✓**
- d) Ersatz der medizinischen Akuttherapie durch Sport

Warum: Nur der Erhalt der Leistungsfähigkeit und die Rückkehr in den Sportalltag stehen im Foliensatz; die übrigen widersprechen der Nachsorge-Ausrichtung.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

3. Welche Zieldimension gehört laut Foliensatz zu den Zielen des Sporttreibens?

- a) Ökonomische Ziele
- b) **Ästhetische Ziele ✓**
- c) Juristische Ziele
- d) Kommerzielle Ziele

Warum: Der Foliensatz listet ästhetische Ziele; ökonomische, juristische und kommerzielle Ziele erscheinen nicht als Dimensionen.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

4. Was nennt der Foliensatz als Gründe für fehlendes Bewegungsverhalten onkologisch erkrankter Kinder?

- a) Ausschließlich fehlendes elterliches Interesse
- b) **Nebenwirkungen, fehlende Anreize und Bewegungsräume, Unsicherheiten und Rückzugverhalten ✓**
- c) Vor allem die finanziellen Kosten der Sportvereine
- d) Ein grundsätzliches Sportverbot durch Ärzt*innen

Warum: Nur diese Aufzählung entspricht den Folienangaben; die übrigen Gründe werden nicht genannt.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

5. Welche Aussage entspricht der Take-home-Message?

- a) Limitierungen sind bedeutsamer als Potentiale
- b) Heterogenität soll vermieden und ausgeglichen werden
- c) **Potentiale sind bedeutsamer als Limitierungen, Heterogenität produktiv nutzen ✓**
- d) Sport eignet sich kaum zur Vermittlung von Teilhabe

Warum: Nur diese Aussage gibt die Take-home-Message korrekt wieder; die anderen kehren die Kernbotschaft um.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

6. Ab welcher voraussichtlichen Dauer der Abweichung gilt man laut SGB IX als behindert?

- a) Länger als 3 Monate

b) Länger als 6 Monate ✓

c) Länger als 12 Monate

d) Länger als 24 Monate

Warum: SGB IX: Abweichung mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate vom alterstypischen Zustand.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

7. Welchen Stellenwert hat Krebs laut Foliensatz als Todesursache im Kindesalter?

a) Zweithäufigste Todesursache ✓

b) Häufigste Todesursache

c) Dritthäufigste Todesursache

d) Seltene Todesursache

Warum: Der Foliensatz (Kinderkrebsregister) nennt Krebs als zweithäufigste Todesursache im Kindesalter.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

8. Welche positiven Effekte körperlicher Aktivität nennt der Foliensatz?

a) Bessere Schulnoten und schnellere Heilung des Tumors

b) Höhere Medikamentendosis und kürzere Aufenthalte

c) Physische Leistungsfähigkeit, Fatigue und Lebensqualität ✓

d) Geringeres Rückfallrisiko und weniger Nebenwirkungen

Warum: Genannt werden Effekte auf physische Leistungsfähigkeit, Fatigue und Lebensqualität; die anderen Wirkungen stehen nicht im Text.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

9. Welches Recht erkennt Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention laut Foliensatz an?

a) Recht auf kostenlose medizinische Versorgung

b) Recht auf inklusive Beschulung

c) Recht auf Schutz vor körperlicher Überlastung

d) Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel ✓

Warum: Artikel 31 nennt das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel; die anderen Rechte betrifft er nicht.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

10. Wie viele Verletzungen durch die Sportangebote nennt der Foliensatz (2022-2024)?

a) 0 Verletzungen ✓

b) 3 Verletzungen

c) 12 Verletzungen

d) unbekannt

Warum: Der Foliensatz gibt für die Sportangebote 0 Verletzungen an; die anderen Zahlen stehen nicht im Text.

Beleg: Sitzung 08 (Boll), Foliensatz

11. Wie viele Krebs-Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wurden laut Kinderkrebsregister für 2019 gemeldet?

a) 1755 Erkrankungen

b) 2255 Erkrankungen ✓

c) 2055 Erkrankungen

d) 2555 Erkrankungen

Warum: Der Foliensatz nennt für 2019 exakt 2255 gemeldete Erkrankungen; die übrigen Zahlen stehen nicht im Text.

Beleg: Foliensatz Sitzung 08 Onkologie/Natursport (Boll), Kinderkrebsregister 2019

12. Wie viele bewegte Patient*innen nennt der Foliensatz in den aktuellen Zahlen (2022-2024)?

a) 147 Patient*innen

b) 91 Patient*innen

c) 69 Patient*innen ✓

d) 317 Patient*innen

Warum: 69 sind die bewegten Patient*innen, während 147 die bewegten Eltern & Geschwister, 91 die Teamer*innen und 317 die 'glücklichen Menschen' bezeichnen.

Beleg: Foliensatz Sitzung 08 Onkologie/Natursport (Boll), Aktuelle Zahlen & Fakten 2022-2024

Sitzung 09 — Handball-Heroes & Special Olympics Unified

02.07 · Schneider / Hermann

Zusammenfassung

Zwei inklusive Praxisprojekte: die Glücksliga (Handball) und Special Olympics Unified (Beachvolleyball Münster).

Die Glücksliga geht auf die dänische Idee der 'LykkeLiga' zurück: Im August 2017 gründete Rikke Aalborg das erste Handballteam für behinderte Kinder. Seit 2021 gibt es die Glücksliga Deutschland, die Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ermöglichen soll, ihrem Lieblingssport nachzugehen; die Sparta Heroes sind eine solche inklusive Handballmannschaft. Zur Gründung eines Glücksteams müssen zunächst Rahmenbedingungen geklärt werden (Vereinskooperation, Trainingszeiten, Zielgruppe, TrainerInnen, Name), danach folgen Aufgabenverteilung (z.B. Mitgliedsbeiträge, Logo, Förderanträge, Homepage) und Werbung über Flyer, Schulen und Social Media bis zum ersten Training. Unified Sport ist ein Konzept von Special Olympics: das gemeinsame Sporttreiben von Menschen mit und ohne geistige Behinderung in verschiedenen Sportarten, von freizeit- bis wettkampforientiert. Das Unified-Beachvolleyballteam Münster besteht aus Athlet*innen und Unified-Partner*innen und wurde im Januar 2024 gegründet. Das Unified-Beachvolleyballteam Münster entstand aus einem Projektseminar der Uni Münster zu den World Games 2023 und nahm u.a. 2024 an der Europameisterschaft in Bratislava als Team Germany teil; ein großes Ziel sind die World Games Chile 2027.

Karteikarten (9)

1. **Woher stammt die Idee der Glücksliga, und wie heißt sie im Ursprungsland?**
Aus Dänemark; dort heißt sie 'LykkeLiga' (Glücksliga).
2. **Seit wann gibt es die Glücksliga Deutschland und für wen?**
Seit 2021 – sie soll Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ermöglichen, ihrem Lieblingssport nachzugehen.
3. **Was bedeutet Unified Sport und von wem stammt das Konzept?**
Gemeinsames Sporttreiben von Menschen mit und ohne geistige Behinderung; ein Konzept von Special Olympics.
4. **Aus welchen zwei Rollen setzt sich das Unified-Beachvolleyballteam Münster zusammen?**
Aus Athlet*innen und Unified-Partner*innen.
5. **Welche Rahmenbedingungen sind vor Gründung eines Glücksteams zu klären?**
Vereinskooperation, Trainingszeiten, Zielgruppe, Name und TrainerInnen.
6. **Was ist das sportliche Fernziel des Unified-Beachteams Münster?**
Teilnahme an den World Games 2027 in Chile.
7. **In welcher Reihenfolge verlaufen die vier Schritte zur Gründung eines Glücksteams?**
Rahmenbedingungen → Aufgabenverteilung → Werbung → erstes Training.
8. **Welche Aufgaben fallen im Schritt 'Aufgabenverteilung' an?**
Anbindung an die Glücksliga, Mitgliedsbeiträge, Logo erstellen, Förderanträge und Homepage.
9. **Wie kam das Unified-Beachvolleyballteam Münster zur Teilnahme an den World Games 2023?**
Über das Projektseminar der Uni Münster.

Prüfungsfragen (10)

1. **Aus welchem Land stammt die ursprüngliche Idee der Glücksliga?**

a) Dänemark ✓

- b) Norwegen
- c) Niederlande
- d) Schweden

Warum: Die Folien nennen ausdrücklich Dänemark als Ursprung der 'LykkeLiga'; die anderen Länder werden nicht erwähnt.

Beleg: Sitzung 09 (Schneider/Hermann), Foliensatz

2. Seit welchem Jahr gibt es die Glücksliga Deutschland?

- a) Seit 2017
- b) Seit 2019
- c) **Seit 2021 ✓**
- d) Seit 2023

Warum: Laut Folie besteht die Glücksliga Deutschland seit 2021; 2017 bezieht sich auf das erste dänische Team.

Beleg: Sitzung 09 (Schneider/Hermann), Foliensatz

3. Was kennzeichnet das Unified-Prinzip von Special Olympics?

- a) **Menschen mit und ohne geistige Behinderung spielen gemeinsam im selben Team ✓**
- b) Nur Menschen mit geistiger Behinderung bilden ein Team
- c) Menschen mit Behinderung treten getrennt gegen Teams ohne Behinderung an
- d) Menschen ohne Behinderung übernehmen ausschließlich Betreuungsaufgaben

Warum: Unified bedeutet gemeinsames Spielen im selben Team; die anderen Optionen widersprechen dem inklusiven Grundprinzip.

Beleg: Sitzung 09 (Schneider/Hermann), Foliensatz

4. Wie werden die Mitglieder des Unified-Beachvolleyballteams Münster bezeichnet?

- a) **Athlet*innen und Unified-Partner*innen ✓**
- b) Spieler*innen und Betreuer*innen
- c) Aktive und Fördermitglieder
- d) Athlet*innen und Trainer*innen

Warum: Die Folie unterscheidet ausdrücklich Athlet*innen und Unified-Partner*innen; die übrigen Bezeichnungen tauchen nicht auf.

Beleg: Sitzung 09 (Schneider/Hermann), Foliensatz

5. Wie heißt die dänische Ursprungsidee, auf der die Glücksliga basiert?

- a) **LykkeLiga ✓**
- b) GladLiga
- c) HjerteLiga
- d) SolLiga

Warum: Die Glücksliga geht auf die dänische LykkeLiga zurück (erstes Team August 2017); die anderen Namen sind erfunden.

Beleg: Sitzung 09 (Schneider/Hermann), Foliensatz

6. Wann wurde das Unified-Beachvolleyballteam Münster gegründet?

- a) **Januar 2024 ✓**
- b) Januar 2023
- c) Januar 2025
- d) Januar 2022

Warum: Die Gründung erfolgte im Januar 2024, nach den World Games 2023; die anderen Jahre widersprechen der Folie.

Beleg: Sitzung 09 (Schneider/Hermann), Foliensatz

7. In welcher Reihenfolge verlaufen die vier Schritte zur Gründung eines Glücksteams?

- a) **Rahmenbedingungen → Aufgabenverteilung → Werbung → erstes Training ✓**

- b) Werbung → Rahmenbedingungen → Aufgabenverteilung → erstes Training
- c) Aufgabenverteilung → Rahmenbedingungen → Werbung → erstes Training
- d) Rahmenbedingungen → Werbung → Aufgabenverteilung → erstes Training

Warum: Die Folien geben genau diese Abfolge vor; in den anderen Optionen stehen die Schritte in der falschen Reihenfolge.

Beleg: Foliensatz Sitzung 09 Glücksliga (Schneider), 4-Schritte-Gründungsprozess

8. Wer gründete im August 2017 das erste Handballteam für Kinder mit Behinderung, aus dem die Glücksliga-Idee hervorging?

- a) Louisa Schneider
- b) Marion Golenia
- c) Rikke Aalborg ✓**
- d) Special Olympics

Warum: Die Folie nennt Rikke Aalborg als Gründerin des ersten dänischen Teams 2017; die anderen sind Referentinnen bzw. eine fremde Organisation.

Beleg: Foliensatz Sitzung 09 Glücksliga (Schneider), Ursprung Dänemark/Rikke Aalborg

9. Unter welchem Namen trat das Unified-Beachvolleyballteam bei der Europameisterschaft 2024 in Bratislava an?

- a) Team Münster
- b) Team Germany ✓**
- c) Team Sparta
- d) Team Special Olympics

Warum: Laut Folie startete das Team bei der EM 2024 in Bratislava als 'Team Germany'; die anderen Bezeichnungen kommen nicht vor.

Beleg: Foliensatz Sitzung 09 Unified Beachvolleyball Münster, EM 2024 Bratislava

10. An welchem nationalen Wettkampf nimmt das Unified-Beachvolleyballteam Münster 2026 teil?

- a) Nationale Spiele in Münster
- b) Nationale Spiele in Bratislava
- c) Nationale Spiele in Chile
- d) Nationale Spiele im Saarland ✓**

Warum: Die Folie nennt die Nationalen Spiele 2026 im Saarland; Bratislava gehört zur EM 2024 und Chile zu den World Games 2027.

Beleg: Foliensatz Sitzung 09 Unified Beachvolleyball Münster, Nationale Spiele Saarland 2026

Sitzung 10 — Teilhabe: Teilnahme, Teilgabe, Teilsein

09.07 · Jürgens

Zusammenfassung

Gleichberechtigte Teilhabe im Sportunterricht — die Trias Teilnahme, Teilgabe, Teilsein und Regelmodifikationen.

Aufbauend auf der Wertschätzung menschlicher Vielfalt im inklusiven Unterricht haben alle Schülerinnen und Schüler auch im Sportunterricht das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe (Tiemann & Hofmann, 2010). Zur Analyse gleichberechtigter Teilhabe an Spielen im Sportunterricht unterscheidet das Modell die Formen Teilnahme, Teilgabe, Nicht-Teilnahme und Teilsein; es geht auf Jürgens (2020) in Anlehnung an Pfitzner (2017) und Heimlich (2014) zurück. Die Teilhabebformen werden im Modell über Dimensionen wie motorische Spielhandlungen, Kommunikation, Beitrag zum Gelingen, Variabilität und Emotionen betrachtet. Teilhabe umfasst nach Boban & Hinz (2006) u.a. Akzeptanz, Wahrnehmung und Wertschätzung eines jeden sowie das gemeinsame Lernen und Zusammenarbeiten mit anderen. Zur Verbesserung der gleichberechtigten Teilhabe setzen Schüler:innen und Lehrkraft an Regelmodifikationen an – in den Bereichen Personal, Raum, Zeit, Handlungen und Inventar (Westermann, 2016).

Karteikarten (9)

- 1. Welche drei Begriffe bilden die Trias, mit der gleichberechtigte Teilhabe ausdifferenziert wird?**
Teilnahme, Teilgabe und Teilsein (im Modell zusätzlich: Nicht-Teilnahme).
- 2. Auf welche Autoren geht das Modell 'Gleichberechtigte Teilhabe an Spielen im Sportunterricht' zurück?**
Auf Jürgens (2020) in Anlehnung an Pfitzner (2017) und Heimlich (2014).
- 3. Über welche Dimensionen wird Teilhabe im Modell betrachtet?**
Motorische Spielhandlungen, Kommunikation, Beitrag zum Gelingen, Variabilität und Emotionen.
- 4. In welchen fünf Bereichen können nach Westermann (2016) Regelmodifikationen ansetzen?**
Personal, Raum, Zeit, Handlungen und Inventar.
- 5. Was umfasst Teilhabe nach Boban & Hinz (2006)?**
Akzeptanz, Wahrnehmung, Wertschätzung eines jeden sowie mit anderen gemeinsam zu lernen und zusammenzuarbeiten.
- 6. Welches Recht haben nach Tiemann & Hofmann (2010) alle Schüler:innen im Sportunterricht?**
Das Recht auf eine gleichberechtigte Teilhabe – aufbauend auf der Wertschätzung menschlicher Vielfalt.
- 7. Welche zwei Teilprozesse kennzeichnen die Professionelle Unterrichtswahrnehmung (PUW)?**
Selektive Aufmerksamkeitssteuerung und wissensbasierte Deutungen.
- 8. Wodurch kann die PUW gefördert werden?**
Durch Videotraining – u.a. wegen fehlendem Handlungsdruck und Theorie-Praxis-Bezug.
- 9. Welche Fehlerarten der Unterrichtswahrnehmung nennt der Foliensatz?**
Wahrnehmungs-, Erinnerungs-/Wiedergabe- und Interpretations-/Deutungsfehler.

Prüfungsfragen (11)

- 1. Welche drei Formen bilden die Trias der Teilhabe im Foliensatz?**
 - a) Teilnahme, Teilgabe und Teilsein ✓
 - b) Integration, Inklusion und Teilhabe

- c) Akzeptanz, Wahrnehmung und Wertschätzung
- d) Personal, Raum und Inventar

Warum: Integration/Inklusion, Akzeptanz/Wahrnehmung (Boban & Hinz) und Personal/Raum (Regelmodifikationen) stammen aus anderen Folienstellen und bilden nicht die Trias.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

2. Welche zwei weiteren Formen ergänzt das Modell neben 'Teilnahme' und 'Nicht-Teilnahme'?

- a) Variabilität und Emotionen
- b) Integration und Inklusion
- c) Teilgabe und Teilsein ✓**
- d) Akzeptanz und Wertschätzung

Warum: Variabilität/Emotionen sind Dimensionen des Modells; Integration/Inklusion und Akzeptanz/Wertschätzung stammen aus anderen Folien und sind keine Teilhabebformen.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

3. Auf welche Autoren geht das Modell 'Gleichberechtigte Teilhabe an Spielen' zurück?

- a) Boban & Hinz (2006) und Schmelzer (2012)
- b) Tiemann (2019) und Wolters (2015)
- c) Westermann (2016) und Merz-Atalik (2016)
- d) Jürgens (2020) in Anlehnung an Pfitzner (2017) und Heimlich (2014) ✓**

Warum: Boban & Hinz, Schmelzer, Tiemann, Wolters, Westermann und Merz-Atalik werden für andere Inhalte zitiert, nicht als Quelle dieses Modells.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

4. In welchem Bereich können nach Westermann (2016) Regelmodifikationen ansetzen?

- a) Emotionen
- b) Inventar ✓**
- c) Kommunikation
- d) Teilgabe

Warum: Emotionen und Kommunikation sind Dimensionen der Teilhabe und Teilgabe eine Teilhabebform – nur Inventar zählt zu den Regelmodifikationsbereichen.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

5. Welche Aussage zum Recht auf Teilhabe entspricht dem Foliensatz (Tiemann & Hofmann, 2010)?

- a) Nur Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf haben Anspruch auf Teilhabe
- b) Teilhabe ist im Sportunterricht rechtlich nicht verankert
- c) Aufbauend auf der Wertschätzung menschlicher Vielfalt haben alle Schüler das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe ✓**
- d) Teilhabe meint ausschließlich die motorische Teilnahme am Spiel

Warum: Die anderen Aussagen widersprechen dem Folientext, der das Teilhaberecht allen Schülern und über die reine motorische Teilnahme hinaus zuspricht.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

6. Was gehört nach Boban & Hinz (2006) zum Begriff der Teilhabe?

- a) Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden ✓**
- b) Selektive Aufmerksamkeitssteuerung
- c) Teilgabe und Teilsein
- d) Reaktivitätseffekt und Übermittlungsprobleme

Warum: Selektive Aufmerksamkeit sowie Reaktivitätseffekt/Übermittlungsprobleme stammen aus dem Teil zur Unterrichtswahrnehmung, und Teilgabe/Teilsein sind Formen des Modells, nicht Boban & Hinz' Teilhabebegriff.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

7. Welche drei Begriffe stellt Heimlich (2014) im Titel gegenüber?

- a) **Teilhabe, Teilgabe und Teilsein** ✓
- b) Teilnahme, Teilgabe und Nicht-Teilnahme
- c) Integration, Inklusion und Teilhabe
- d) Teilhabe, Teilnahme und Variabilität

Warum: Heimlich's Titel (2014) lautet 'Teilhabe, Teilgabe oder Teilsein?'; die anderen mischen Begriffe aus anderen Folien.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

8. Welchen dritten Begriff nennt die Folie neben Integration und Inklusion (Schmelzer 2012)?

- a) Teilnahme
- b) **Teilhabe** ✓
- c) Teilsein
- d) Teilgabe

Warum: Schmelzer (2012) stellt Integration, Inklusion und Teilhabe nebeneinander; die anderen sind Formen des Teilhabemodells.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

9. Welcher Kategorie stellt das Modell die 'Teilnahme' gegenüber?

- a) Teilgabe
- b) Teilsein
- c) **Nicht-Teilnahme** ✓
- d) Variabilität

Warum: Das Modell listet 'Teilnahme' und 'Nicht-Teilnahme' als Gegenpaar; Teilgabe/Teilsein sind weitere Formen, Variabilität eine Dimension.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

10. Welches gehört zu den vier Prinzipien inklusiver Didaktik (Tiemann, 2019)?

- a) Standardisierung der Lernwege
- b) **Wertschätzung von Unterschiedlichkeit** ✓
- c) Homogenisierung der Lerngruppe
- d) Fokussierung auf Leistungsnormen

Warum: Genannt werden Wertschätzung von Unterschiedlichkeit, Fokussierung der Potentiale, Diversitätssensibilität und Reflexion; die anderen sind deren Gegenteil.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

11. Welcher Aspekt wird im Modell 'Gleichberechtigte Teilhabe an Spielen' genannt?

- a) **Motorische Spielhandlungen** ✓
- b) Schriftliche Reflexion
- c) Notengebung im Sport
- d) Soziale Herkunft

Warum: Das Modell nennt u.a. motorische Spielhandlungen, Kommunikation, Beitrag zum Gelingen, Variabilität und Emotionen.

Beleg: Sitzung 10 (Jürgens), Foliensatz

Sitzung 11 — Inklusion & Exklusion im Leistungssport

16.07 · Konjer

Zusammenfassung

Inklusion und Exklusion im Leistungssport: Geschlechterklassen, Testosteron, die Wellenbewegung der Regularien und das IOC-Framework.

Die Geschlechtertrennung im Sport beruht auf zwei Annahmen: Es gebe nur zwei biologisch eindeutig bestimmbare Geschlechter, und die Geschlechtszugehörigkeit determiniere die sportliche Leistung. Die Geschlechterklassen fungieren daher als Leistungsklassen zur Sicherung der Chancengleichheit, mit wenigen Ausnahmen wie Segeln, Reiten oder Teilen des Motorsports. Als Begründung für die Trennung gelten hormonelle Unterschiede: Männer haben im Regelfall eine 10-20x höhere Testosteron-Konzentration (im Schnitt 17 nmol/l gegenüber meist unter 2 nmol/l bei Frauen). Der Leistungsvorteil ist bei schnellkräftig-explosiven Sportarten mit 20-50% besonders hoch, bei Ausdauerleistungen geringer (ca. 10%). Die Regularien verlaufen als historische Wellenbewegung: von restriktiv (Phase 1 bis 1992, u.a. IOC-Geschlechtstests ab 1968, Chromosomentests ab 1976) über eine Öffnungsphase (ab 1992, Tests abgeschafft, Stockholm Consensus 2004) bis zu einer erneuten Restriktion (Phase 3 ab 2021). Das IOC veröffentlichte 2021 ein 'Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination', hob die eigene 5 nmol/l-Testosteron-Regel auf und wies die Mitgliedsverbände an, eigene inklusive Regelungen auf Basis von Fairness, Nicht-Diskriminierung und wissenschaftlicher Evidenz zu finden. In der Folge verschärften mehrere Verbände (z.B. World Athletics, World Aquatics, World Boxing) ihre Regeln teils bis hin zu genetischen Geschlechtstests. Als Fazit zeigt sich, dass der gesellschaftliche Umgang mit Non-Binarität, Transgender und DSD zunehmend offener wird, während der Spitzensport nach relativ inklusiven Regelungen nun einen Trend zur bedingungslosen Exklusion aufweist. Testosteron gilt als DIE Bezugsgröße für Chancengleichheit, und Geschlechtstests kehren zurück.

Karteikarten (13)

1. Auf welchen zwei Annahmen basiert die Existenz der Geschlechterklassen im Sport?

1. Es gibt nur zwei, biologisch eindeutig zu bestimmende Geschlechter. 2. Die Geschlechtszugehörigkeit determiniert die sportliche Leistung. Daher fungieren Geschlechterklassen als Leistungsklassen.

2. Welche Testosteron-Durchschnittswerte nennt der Foliensatz für Männer und Frauen?

Männer im Schnitt 17 nmol/l, Frauen meist unter 2 nmol/l (Männer 10-20x höher).

3. Wie unterscheidet sich der männliche Leistungsvorteil je nach Sportart?

Bei schnellkräftig-explosiven Sportarten besonders hoch (20-50%); je wichtiger die Ausdauer, desto geringer (ca. 10%).

4. Was ist der Kern des Falls Lia Thomas?

US-Schwimmerin, gewinnt 2022 nach 2021 abgeschlossener Transition als erste Transgender-Frau die NCAA-Meisterschaft über 500m; im selben Jahr schließt der Weltschwimmverband alle Transfrauen aus, die eine männliche Pubertät durchlaufen haben.

5. Was beinhaltete das IOC-Framework von 2021?

Unterstützung von Inklusion, Nicht-Diskriminierung und Gesundheit aller Athlet:innen; Aufhebung der eigenen 5 nmol/l-Regel; Auftrag an die Verbände, eigene inklusive Regelungen auf Basis von Fairness, Nicht-Diskriminierung und Evidenz zu finden.

6. Was bezeichnet DSD (Differences in Sex Development)?

Varianten der Geschlechtsentwicklung, bei denen die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale (Chromosomen, Gonaden, Hormone, äußere Organe) nicht typisch männlich oder weiblich verläuft.

7. Um welchen Faktor ist der Testosteronwert bei Männern im Regelfall höher?

10-20x höher als bei Frauen.

8. Wie groß ist der Leistungsunterschied bei Ausdauerleistungen?

Geringer, ca. 10 %.

9. Welche Sportarten sind Ausnahmen von den Geschlechterklassen?

Segeln, Reiten, in Teilen Motorsport (sowie Mannschaftssport vorpubertärer Jahrgänge).

10. Was führte World Aquatics 2023 zusätzlich ein?

Eine offene Kategorie für Athlet:innen, die die Regeln nicht erfüllen können/wollen.

11. Was verkündete das IOC am 26.03.2026 — und was ersetzt es?

Die 'Policy on the Protection of the Female (Women's) Category' (Präsidentin Kirsty Coventry), in Kraft ab Olympia 2028 in Los Angeles. Sie ersetzt das seit 2021 geltende 'Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination' und sieht genetische Geschlechtstests (SRY-Gentest) für die Frauenklasse vor — ein Kurswechsel zu restriktivem Umgang.

12. Warum gilt der SRY-Gentest laut Offenem Brief nur als bedingt geeignet?

Er prüft nur das Vorhandensein des SRY-Gens, nicht dessen Funktionsfähigkeit. Varianten wie die 46,XY-Androgeninsensitivität oder das 47,XXY-Klinefelter-Syndrom fallen positiv aus, ohne einem männlichen Geschlechtskörper zu entsprechen; ein Y-Chromosom bedeutet nicht automatisch mehr Testosteron oder Leistung.

13. Welche Eckdaten nennt Konjer zur Geschichte der Geschlechtstests ('Wellenbewegung')?

1968 führt das IOC Geschlechtstests ein, 1976 folgen Chromosomentests bei Olympia, 1992 werden die Tests offiziell abgeschafft, 2004 folgt der Stockholm Consensus — Restriktion, Öffnung, erneute Restriktion.

Prüfungsfragen (16)**1. Welche durchschnittliche Testosteronkonzentration nennt der Foliensatz für Männer?**

- a) 17 nmol/l ✓
- b) 5 nmol/l
- c) 2 nmol/l
- d) 2,5 nmol/l

Warum: 2 nmol/l ist der Frauenwert; 5 und 2,5 nmol/l sind Regel-Grenzwerte von Verbänden, nicht der männliche Durchschnitt.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

2. Wie wird der männliche Leistungsvorteil bei schnellkräftig-explosiven Sportarten beziffert?

- a) ca. 10%
- b) genau 17%
- c) 20-50% ✓
- d) über 90%

Warum: Ca. 10% gilt für Ausdauerleistungen, 17% ist ein Testosteronwert und über 90% wird nicht genannt.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

3. Was tat das IOC 2021 mit seiner bisherigen 5 nmol/l-Testosteron-Regel?

- a) Es verschärfte sie auf 2,5 nmol/l
- b) Es führte zusätzlich genetische Geschlechtstests ein
- c) Es übertrug sie unverändert an alle Verbände
- d) Es hob die eigene Regelung auf und delegierte an die Verbände ✓

Warum: Die Verschärfung auf 2,5 nmol/l und genetische Tests stammen von einzelnen Verbänden, nicht vom IOC-Framework, das die Regel gerade aufhob.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

4. Welche Aussage zum Fall Caster Semenya entspricht dem Foliensatz?

- a) 2018 führte der Weltverband eine disziplinspezifische Hyperandrogenismus-Regel für 400m bis 1.500m ein ✓
- b) Sie wurde nach ihrem WM-Gold sofort lebenslang gesperrt
- c) Der CAS hob 2019 sämtliche Hyperandrogenismus-Regeln endgültig auf
- d) Sie ist eine US-amerikanische Schwimmerin

Warum: Eine sofortige lebenslange Sperre wird nicht genannt, der CAS bestätigte 2019 die Regel statt sie aufzuheben, und Semenya ist südafrikanische Mittelstreckenläuferin.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

5. Wie wird die historische Entwicklung der Regularien im Leistungssport charakterisiert?

- a) Als stetig zunehmende Öffnung ohne Rückschritte
- b) Als durchgehend restriktive Linie seit 1950
- c) Als Wellenbewegung von restriktiv über Öffnung zur erneuten Restriktion ✓
- d) Als vollständige Abschaffung aller Geschlechterkategorien

Warum: Der Foliensatz beschreibt eine Wellenbewegung mit Phasenwechseln, keine stetige Öffnung, keine durchgehende Restriktion und keine Abschaffung.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

6. Welche Regelung nennt der Foliensatz für den DFB im Umgang mit Transfrauen?

- a) Genereller Ausschluss aller Transfrauen vom Spielbetrieb
- b) Verpflichtende Hormontherapie bis zum 12. Lebensjahr
- c) Transfrauen/Menschen mit Eintrag 'divers' können zumindest im Amateurbereich selbst entscheiden ✓
- d) Einführung genetischer Geschlechtstests als Zulassungskriterium

Warum: Genereller Ausschluss, Hormontherapie und genetische Tests stammen von anderen Verbänden, nicht vom DFB.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

7. Wie definiert der Foliensatz nach Butler (1991) den Begriff GENDER?

- a) Als biologisches Geschlecht, bei Geburt über Geschlechtsmerkmale zugewiesen
- b) Als soziales Geschlecht, durch wiederholte Handlungen und Praktiken hergestellt ✓
- c) Als chromosomale Ausstattung, die die Leistung determiniert
- d) Als hormonelle Konzentration, die über die Wettkampfklasse entscheidet

Warum: GENDER ist das soziale Geschlecht (nach Butler); die anderen Optionen beschreiben sex bzw. rein biologische Merkmale.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

8. Welche Häufigkeit nennt der Foliensatz für Intersexualität?

- a) Ca. 1 von 250 Geburten
- b) Ca. 1 von 2.500 Geburten ✓
- c) Ca. 1 von 25.000 Geburten
- d) Ca. 1 von 500 Geburten

Warum: Der Foliensatz gibt Intersexualität mit ca. 1 von 2.500 Geburten (ca. 0,05 %) an.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

9. Wie beschreibt der Foliensatz den Fall Lia Thomas?

- a) Sie gewann 2022 als erste Transgender-Frau die NCAA-Meisterschaft über 500m ✓
- b) Sie wurde disqualifiziert, weil Erkenntnisse über Intersexualität vorlagen
- c) Sie gewann 2024 Gold im Boxen bei den Spielen in Paris
- d) Sie klagte erfolgreich gegen die Hyperandrogenismus-Regel

Warum: Laut Foliensatz gewann Lia Thomas 2022 als erste Transgender-Frau die NCAA-Meisterschaft über 500m; die anderen Fälle betreffen andere Personen.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

10. Was verschärfte World Athletics laut Foliensatz im Jahr 2025?

- a) Eine 5 nmol/l-Testosteron-Grenze für alle Athletinnen
- b) Eine offene Kategorie für nicht regelkonforme Athleten
- c) Zusammenlegung der Transgender- und DSD-Regularien plus Gentests ✓**
- d) Zulassung von DSD-Athletinnen ohne Androgensensitivität

Warum: Für World Athletics 2025 nennt der Foliensatz die Zusammenlegung der Transgender- und DSD-Regeln und genetische Geschlechtstests.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

11. Wie wird nach ICD-11 laut Foliensatz Transsexualität heute gefasst?

- a) Als psychische Störung der Geschlechtsidentität
- b) Als Gender-Inkongruenz ✓**
- c) Als Variante der Geschlechtsentwicklung (DSD)
- d) Als Hyperandrogenismus

Warum: Der Foliensatz nennt als heutige Fassung (ICD-11) 'Gender-Inkongruenz'; DSD und Hyperandrogenismus sind andere Konzepte.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

12. Was gilt laut Foliensatz aktuell für die Startberechtigung von Imane Khelif?

- a) Dauerhaft von der Frauenkategorie ausgeschlossen
- b) Startberechtigt, solange keine gesicherten Erkenntnisse zum Geschlecht vorliegen ✓**
- c) Nur in einer offenen Kategorie startberechtigt
- d) Nur mit Testosteronwert unter 2,5 nmol/l über 24 Monate

Warum: Der Foliensatz hält fest, dass Khelif aktuell startberechtigt ist, solange keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.

Beleg: Sitzung 11 (Konjer), Foliensatz

13. Was veröffentlichte das IOC am 26. März 2026 unter Präsidentin Kirsty Coventry?

- a) Das "Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination" auf Basis der Geschlechtsidentität
- b) Eine Bestätigung der bestehenden 5-nmol/l-Testosteron-Regel für alle Verbände
- c) Die "Policy on the Protection of the Female (Women's) Category", in Kraft ab Olympia 2028 ✓**
- d) Die Einführung einer verbindlichen offenen Kategorie für trans* und inter* Athlet:innen

Warum: Das Framework stammt von 2021 und wird gerade ersetzt, die 5-nmol-Regel wurde bereits 2021 aufgehoben, und eine offene Kategorie ist eine Regelung einzelner Verbände, nicht der neuen IOC-Policy.

Beleg: Offener Brief IOC-Regularien 2026, Policy Protection Female Category 26.03.2026

14. In welchem Jahr hatte das IOC den nun wiedereingeführten SRY-Gentest ursprünglich abgeschafft?

- a) 2000, nach vehementer Kritik von Athletinnen und Mediziner:innen ✓**
- b) 1968, mit Einführung der ersten Geschlechtstests
- c) 2021, mit dem IOC-Framework
- d) 2011, mit der ersten Hyperandrogenismus-Regel

Warum: 1968 wurden Geschlechtstests eingeführt, 2021 erschien das inklusive Framework und 2011 kam die Hyperandrogenismus-Regel — die Abschaffung des SRY-Gentests erfolgte laut Offenem Brief im Jahr 2000.

Beleg: Offener Brief IOC-Regularien 2026, SRY-Gentest 2000 abgeschafft

15. Wie behandelt der Verband World Boxing laut Folien DSD-Athletinnen mit Androgensensitivität?

- a) Sie dürfen unter 2,5 nmol/l bei den Frauen starten
- b) Sie sind bei den Männern startberechtigt ✓**
- c) Sie starten in einer eigens eingeführten offenen Kategorie
- d) Sie sind vollständig vom Wettkampf ausgeschlossen

Warum: Laut Folien sind DSD-Athletinnen mit Androgensensitivität bei World Boxing bei den Männern startberechtigt; eine 2,5-nmol-Frauenregel, eine offene Kategorie oder ein vollständiger Ausschluss werden dort nicht genannt.

Beleg: Foliensatz Sitzung 11 Leistungssport (Konjer), World Boxing

16. Zu welchem Schluss kommt laut Offenem Brief eine Metastudie aus dem Jahr 2026?

- a) Trans Frauen haben gegenüber Cis-Frauen stets einen klaren Leistungsvorteil
- b) Der SRY-Gentest erfasst die Funktionsfähigkeit des Gens zuverlässig
- c) Cisgeschlechtliche Athletinnen müssen ebenfalls verpflichtend getestet werden
- d) Trans Frauen haben nicht per se einen Leistungsvorteil gegenüber Cis-Sportlerinnen ✓**

Warum: Die Metastudie (Mendes Sieczkowska et al., 2026) verneint einen pauschalen Leistungsvorteil; die anderen Aussagen widersprechen dem Offenen Brief oder betreffen andere Kritikpunkte.

Beleg: Offener Brief IOC-Regularien 2026, Metastudie 2026